

ATENCIÓN Y PRÁCTICAS ESENCIALES DE SALUD

En este módulo se describen los principios de la atención esencial para todas las personas que solicitan atención de salud, incluidas las que sufren trastornos MNS y sus cuidadores. En la primera sección de este módulo se señalan los principios generales de la atención clínica y se procura promover el respeto a la privacidad de las personas que solicitan atención para trastornos MNS, fomentar las buenas relaciones entre los prestadores de atención de salud, los usuarios de los servicios y sus cuidadores y garantizar que se proporcione la atención en una actitud de apoyo, sin juzgar al paciente y sin estigmatizarlo. La segunda sección abarca elementos esenciales de la práctica clínica de salud mental y se procura presentar a los prestadores de atención de salud un panorama breve de la evaluación y el manejo de trastornos MNS en entornos de atención no especializada.

A. PRINCIPIOS GENERALES

- Use habilidades de comunicación eficaces.
- Promueva el respeto y la dignidad.

B. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DE SALUD MENTAL

- Evalúe la salud física.
- Realice una evaluación para determinar si existe un trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias (MNS).
- Trate los trastornos MNS.

A. PRINCIPIOS GENERALES

I. Use habilidades de comunicación eficaces

El uso de habilidades de comunicación eficaces permite a los prestadores de salud brindar atención de buena calidad a adultos, adolescentes y niños con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias (MNS). Tenga en cuenta los siguientes consejos y habilidades básicas de comunicación.

CONSEJO PARA LA COMUNICACIÓN N° 1

Cree un ambiente que facilite la comunicación abierta

- » Reúnase con la persona en un lugar privado, si fuera posible.
- » Muéstrese cordial y realice las presentaciones de una manera culturalmente apropiada.
- » Mantenga el contacto visual y muestre un lenguaje corporal y expresiones faciales que faciliten la confianza.
- » Explique que la información abordada durante la visita se mantendrá confidencial y no se intercambiará sin autorización previa.
- » Si los cuidadores están presentes, sugiera que desea hablar con la persona a solas (salvo que se trate de niños pequeños) y obtenga su consentimiento para compartir la información clínica.
- » Cuando entreviste a una mujer joven, considere la posibilidad de que esté presente otra funcionaria o una cuidadora.

CONSEJO PARA LA COMUNICACIÓN N° 2

Haga participar a la persona

- » Haga participar a la persona (y con su consentimiento, a sus cuidadores y su familia) en todos los aspectos de la evaluación y el manejo tanto como sea posible. Esto incluye a niños, adolescentes y adultos mayores.

CONSEJO PARA LA COMUNICACIÓN N° 3

Comience por escuchar

- » Escuche activamente. Muéstrese comprensivo y sensible.
- » Permítale a la persona hablar sin interrupción.
- » Si los antecedentes son poco claros, sea paciente y pida una aclaración.
- » Con los niños, use un lenguaje que puedan comprender. Por ejemplo, pregunte acerca de sus intereses (juguetes, amigos, la escuela, etc.).
- » Con los adolescentes, transmita que usted comprende sus sentimientos y su situación.

CONSEJO PARA LA COMUNICACIÓN N° 4

Sea amistoso y respetuoso en todo momento y no juzgue a la persona

- » Siempre sea respetuoso.
- » No juzgue a las personas por sus comportamientos y apariencia.

- » Manténgase tranquilo y paciente.

CONSEJO PARA LA COMUNICACIÓN N° 5

Use buenas aptitudes verbales de comunicación

- » Use un lenguaje sencillo. Sea claro y conciso.
- » Use preguntas de interpretación abierta, sintetice y esclarezca los comentarios que usted haga.
- » Resuma y repita los puntos clave.
- » Permita que la persona haga preguntas acerca de la información suministrada.

CONSEJO PARA LA COMUNICACIÓN N° 6

Responda con sensibilidad cuando las personas revelen experiencias difíciles (por ejemplo, acerca de agresión sexual, violencia o lesiones autoinfligidas)

- » Muestre una sensibilidad mayor con los temas difíciles.
- » Recuerde a la persona que lo que le dicen a usted se mantendrá confidencial.
- » Reconozca que puede haber sido difícil para la persona revelar la información.

II. Promueva el respeto y la dignidad

Las personas con trastornos MNS deben ser tratadas con respeto y dignidad, y de una manera culturalmente apropiada.

Como prestador de atención de salud, haga todo lo posible por respetar y promover la voluntad y la preferencia de las personas con trastornos MNS, y apoye y haga participar a esas personas y a sus cuidadores de la manera más inclusiva. Las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias a menudo son más vulnerables a sufrir violaciones de los derechos humanos. Por consiguiente, es esencial que en el entorno de atención de salud, los prestadores promuevan los derechos de las personas con esos trastornos de acuerdo con las normas internacionales sobre derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.*

* Para más información sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad puede consultar: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

LO QUE DEBE HACER

- » Trate a las personas con trastornos MNS con respeto y dignidad
- » Proteja la confidencialidad de las personas con trastornos MNS.
- » Garantice la privacidad en el entorno clínico.
- » Brinde siempre acceso a la información y explique los riesgos y los beneficios del tratamiento propuesto, por escrito si fuera posible.
- » Asegúrese de que la persona otorgue su consentimiento al tratamiento.
- » Promueva la autonomía y la vida independiente en la comunidad.
- » Dé a las personas con trastornos MNS acceso a opciones para tomar decisiones fundadas.

LO QUE NO DEBE HACER

- » No discrimine a las personas con trastornos MNS.
- » No pase por alto las prioridades o los deseos de las personas con trastornos MNS.
- » No tome decisiones acerca, en nombre, o en vez de la persona con trastornos MNS.
- » No use un lenguaje excesivamente técnico al explicar el tratamiento propuesto.

B. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DE SALUD MENTAL

I. Evalúe la salud física

Las personas con trastornos MNS corren un mayor peligro de muerte prematura causada por enfermedades prevenibles y, por consiguiente, siempre deben ser sometidas a una evaluación de su salud física como parte de un examen integral. Asegúrese de tomar nota de los antecedentes adecuados, entre los que se incluyen los antecedentes tanto de salud física como de trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, seguidos de una evaluación de la salud física para detectar enfermedades concurrentes e instruir a la persona acerca de medidas preventivas. Siempre se deben emprender estas acciones con el consentimiento fundamentado de la persona.

Evaluación de la salud física

» **Tome notas detalladas de los antecedentes y pregunte acerca de los factores de riesgo.**

Inactividad física, alimentación inapropiada, consumo perjudicial de tabaco, alcohol u otras sustancias, comportamientos peligrosos y enfermedades crónicas.

» **Realice un examen físico.**

» **Considere un diagnóstico diferencial.**

Descarte trastornos físicos y causas subyacentes de las manifestaciones de MNS mediante las preguntas sobre los antecedentes, el examen físico y las pruebas básicas de laboratorio, según sea necesario y factible.

» **Detecte las comorbilidades.**

A menudo una persona puede tener al mismo tiempo más de un trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias. Es importante evaluar y tratar esto cuando ocurre.



CONSEJO CLÍNICO:

Las personas con trastornos mentales graves tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de morir por enfermedades prevenibles como las infecciones y los trastornos cardiovasculares. Concéntrese en reducir el riesgo mediante la educación y el seguimiento.

Manejo de la salud física

» Trate las comorbilidades existentes en simultáneo con el trastorno MNS. Derive o consulte a especialistas, de ser necesario.

» Instruya al paciente acerca de los factores de riesgo modificables a fin de prevenir las enfermedades y promueva un modo de vida saludable.

» Para apoyar la salud física de las personas con trastornos MNS, los prestadores de atención de salud deben:

- brindar asesoramiento acerca de la importancia de la actividad física y una alimentación saludable;
- instruir a las personas acerca del consumo perjudicial de alcohol;
- promover el abandono del consumo de tabaco y el consumo de sustancias;
- instruir acerca de otros comportamientos peligrosos (por ejemplo, relaciones sexuales sin protección);
- efectuar periódicamente exámenes de salud física y administrar vacunas;
- preparar a las personas para los cambios del desarrollo durante la vida, como la pubertad y la menopausia, y prestarles el apoyo necesario; y
- analizar planes para el embarazo y métodos de anticoncepción con las mujeres en edad fecunda.

II. Realice una evaluación para determinar si existe un trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias

La evaluación para determinar si existen trastornos MNS incluye los pasos indicados a continuación. Primero, se analiza la dolencia que se manifiesta, luego se elabora una historia clínica que incluya preguntas acerca de anteriores problemas mentales, neurológicos o por consumo de sustancias psicoactivas, problemas de salud general, antecedentes familiares de trastornos MNS y antecedentes psicosociales. Observe a la persona (examen del estado mental), formule un diagnóstico diferencial y determine el trastorno MNS. Como parte de la evaluación, efectúe un examen físico y solicite pruebas básicas de laboratorio según sea necesario. La evaluación se realiza con el consentimiento fundamentado de la persona.



HISTORIA CLÍNICA

1 Motivo de consulta

Síntoma o razón principal por el que la persona está solicitando atención.

- » Pregunte cuándo, por qué y cómo comenzó.
- » Es importante en esta etapa recopilar tanta información como sea posible acerca de los síntomas de la persona y su situación.

2 Antecedentes de MNS anteriores

- » Pregunte acerca de problemas similares en el pasado, hospitalizaciones o medicamentos psiquiátricos recetados para trastornos MNS y algún intento anterior de suicidio.
- » Investigue el consumo de tabaco, alcohol y sustancias.

3 Historia clínica general

- » Pregunte acerca de problemas de salud física y los medicamentos usados.
- » Obtenga una lista de los medicamentos usados actualmente.
- » Pregunte acerca de alergias a medicamentos.

4 Antecedentes familiares de trastornos MNS

- » Indague acerca de posibles antecedentes familiares de trastornos MNS y pregunte si algún miembro de la familia tuvo síntomas similares o recibió tratamiento para un trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias psicoactivas.

5 Antecedentes psicosociales

- » Pregunte acerca de factores estresantes actuales, métodos para hacerles frente y apoyo social.
- » Pregunte acerca del funcionamiento socio-ocupacional actual (cómo está funcionando la persona en su hogar, en el trabajo y en sus relaciones).
- » Obtenga información básica sobre cómo y dónde vive la persona, su nivel educativo, sus antecedentes laborales, su estado civil y el número y las edades de sus hijos, sus ingresos y la estructura y condiciones de vida de la familia.

Cuando se trata de niños y adolescentes, pregunte si tienen un cuidador y la naturaleza y calidad de la relación entre ellos.

Si sospecha que existe un trastorno MNS prioritario, vaya al módulo o los módulos pertinentes para la evaluación.



EVALUACIÓN PARA TRASTORNOS DE MNS

1 Examen físico

» Realice un examen físico específico guiado por la información encontrada durante la evaluación para determinar la presencia de trastornos MNS.

2 Examen del estado mental*

» Observe la apariencia y el comportamiento de la persona, su estado de ánimo y afectivo, el contenido de sus pensamientos y alguna posible alteración de la percepción y la cognición y hágale preguntas sobre todo esto. Vea los detalles en el Esquema principal conforme a los síntomas.

3 Diagnóstico diferencial

» Considere el diagnóstico diferencial y descarte afecciones que se manifiestan con síntomas similares a los ahora observados.

4 Pruebas de laboratorio básicas

» Solicite pruebas de laboratorio cuando estén indicadas y sean factibles, especialmente para descartar causas físicas.

5 Determine el trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias

» Identifique el trastorno MNS usando el módulo o los módulos apropiados.
» Determine si existen síntomas de otros trastornos MNS prioritarios (vea el Esquema principal).
» Siga el algoritmo de manejo y los protocolos de tratamiento apropiados.



CONSEJO CLÍNICO:

Cuando sospeche que existe un trastorno MNS, evalúe siempre la posibilidad de autolesión/ suicidio (»SUI)

*El examen del estado mental adaptado para no especialistas puede incluir: comportamiento y apariencia = los síntomas y signos relacionados con la forma en que se ven y actúan las personas; estado de ánimo y afectivo = los síntomas y signos relacionados con el control y la expresión de las emociones o los sentimientos; contenido del pensamiento = los síntomas y signos relacionados con los temas abarcados en los pensamientos, incluidos los delirios, la paranoia, la suspicacia y la ideación suicida; alteración de la percepción = percepciones sensoriales que se producen en ausencia del estímulo (externo) apropiado (por ejemplo, alucinaciones auditivas o visuales)(la persona puede o no tener conocimiento de la naturaleza irreal de la percepción); alteración de la cognición = los síntomas, signos y resultados clínicos indicativos de un trastorno de las capacidades y procesos mentales relacionados con la atención, la memoria, el juicio, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión y la integración de estas funciones.

III. Trate los trastornos MNS

Una vez efectuada la evaluación, siga el algoritmo de manejo indicado en la GI-mhGAP para tratar el trastorno MNS. Se señalan los pasos clave del manejo en el cuadro mostrado a continuación.



PASOS DEL MANEJO DE TRASTORNOS MNS

*Muchos trastornos MNS son crónicos y requieren vigilancia y seguimiento a largo plazo.
El manejo de un trastorno MNS en el transcurso del tiempo incluye los pasos indicados a continuación.*

- 1 **Elabore un plan de tratamiento en colaboración con la persona y su cuidador.**



CONSEJO CLÍNICO:

El plan escrito de tratamiento debe incluir:

- intervenciones farmacológicas (si las hay),
- intervenciones psicosociales,
- derivaciones,
- plan de seguimiento, y
- tratamiento de todo trastorno físico concurrente o de otro tipo de trastorno MNS.

- 2 Brinde siempre **intervenciones psicosociales** a la persona y sus cuidadores.
- 3 Trate el trastorno MNS usando **intervenciones farmacológicas** cuando estén indicadas.

- 4 **Derive al paciente** a especialistas o al hospital cuando esté indicado y sea factible.
- 5 Asegúrese que se ha elaborado un plan apropiado de **seguimiento**.
- 6 **Trabaje de manera conjunta** con el cuidador y la familia al apoyar a la persona con un trastorno MNS.
- 7 Fomente el establecimiento de **vínculos sólidos** con los sectores del empleo, la educación, los servicios sociales (incluida la vivienda) y otros sectores pertinentes.
- 8 Modifique los planes de tratamiento para los **grupos especiales de población**.

1 Planificación del tratamiento

- » Examine y determine metas del tratamiento que respeten la voluntad y las preferencias del paciente en cuanto a la atención.
- » Incluya al cuidador después de obtener el consentimiento de la persona.
- » Promueva la autovigilancia de los síntomas y explique cuándo se debe solicitar atención con urgencia.

2 Intervenciones psicosociales

A. Psicoeducación

Suministre a la persona información acerca del trastorno MNS, en especial sobre:

- »Cuál es el trastorno, la evolución y los resultados esperados;
- » Los tratamientos disponibles para el trastorno y los beneficios esperados;
- » La duración del tratamiento;
- » La importancia de cumplir el tratamiento, incluido lo que puede hacer la persona (por ejemplo, tomar medicamentos o realizar intervenciones psicológicas pertinentes, como los ejercicios de relajación) y qué pueden hacer los cuidadores para ayudarla a cumplir las indicaciones del tratamiento;
- » Posibles efectos secundarios (a corto y a largo plazo) de todo medicamento prescrito, que la persona debe vigilar, al igual que sus cuidadores; y
- » La posible participación de asistentes sociales, encargados de los casos, agentes comunitarios de salud u otros miembros de confianza de la comunidad.
- » **Consulte la sección de “Manejo” del módulo o los**

módulos pertinentes para obtener información específica sobre el trastorno MNS.

B. Reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales

Aborde los factores psicosociales estresantes actuales:

- » Detecte y aborde los problemas psicosociales pertinentes que causan estrés a la persona o repercuten en su vida, incluidos: problemas familiares y de relaciones, problemas económicos o vinculados con el empleo, la ocupación, los medios de vida, la vivienda, el acceso a la seguridad y los servicios básicos, la estigmatización y la discriminación, etc.
- » Ayude a la persona a controlar el estrés mediante métodos tales como las técnicas de resolución de problemas.
- » Evalúe y aborde toda situación de maltrato o abuso (por ejemplo, la violencia doméstica), y de descuido (por ejemplo, de niños o ancianos). Examine con la persona la posibilidad de derivarla a un organismo confiable de protección o a una red informal de protección. Póngase en contacto con la asistencia legal y los recursos de la comunidad, según proceda.
- » Identifique los familiares que pueden prestar apoyo y haga que participen tanto como sea posible y apropiado.
- » Fortalezca los apoyos sociales y trate de reactivar las redes de relaciones sociales de la persona.
- » Determine las actividades sociales anteriores que, si se reiniciaran, podrían prestar apoyo psicosocial directo o indirecto (por ejemplo, reuniones familiares, visitas a vecinos, actividades de la comunidad, actividades religiosas, etc.).
- » Enseñe cómo abordar el estrés, por ejemplo, mediante técnicas de relajación.

C. Promueva el funcionamiento adecuado en las actividades diarias

- » Preste apoyo a la persona para que, en la medida de lo posible, continúe sus actividades sociales, educativas y ocupacionales ordinarias.
- » Facilite su participación en actividades económicas.
- » Ofrezca capacitación en habilidades para la vida y en habilidades sociales, de ser necesario.

D. Tratamiento psicológico

Los tratamientos psicológicos son intervenciones que normalmente requieren dedicarles un tiempo considerable y suelen ser suministrados por especialistas capacitados. No obstante, pueden ser realizados eficazmente por trabajadores no especializados, capacitados y supervisados, y mediante la autoayuda guiada (por ejemplo, con el uso de programas electrónicos sobre salud mental o libros de autoayuda).

Las intervenciones que se señalan a continuación se describen brevemente en el glosario.

<u>Ejemplo de intervención</u>	<u>Recomendado para:</u>
Activación conductual	DEP
Capacitación en técnicas de relajación	DEP
Orientación para la resolución de problemas	DEP
Terapia cognitivo conductual (TCC)	DEP, MCON, SUS, PSI
Terapia de manejo de contingencias	SUS
Orientación o terapia familiar	PSI, SUS
Terapia interpersonal (TIP)	DEP
Terapia de refuerzo motivacional	SUS
Formación en habilidades para padres	MCON

3 Intervenciones farmacológicas

- » Siga las directrices sobre psicofarmacología incluidas en cada módulo.
- » Use intervenciones farmacológicas cuando disponga de ellas y cuando estén indicadas en el algoritmo de manejo y el cuadro proporcionados.
- » Al seleccionar los medicamentos esenciales apropiados, considere el perfil de efectos secundarios de los medicamentos (a corto y largo plazo), la eficacia del tratamiento anterior, las interacciones medicamentosas o las interacciones entre los medicamentos y la enfermedad.
- » Consulte el formulario farmacológico nacional o el formulario de la OMS, según sea necesario.
- » Instruya a la persona acerca de los riesgos y los beneficios del tratamiento, los posibles efectos secundarios, la duración del tratamiento y la importancia de observarlo rigurosamente.
- » Obre con cautela cuando proporcione medicación a grupos especiales como las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas, las mujeres durante el embarazo o la lactancia, y los niños y los adolescentes. Consulte a un especialista según sea necesario.

4 Derivación a un especialista u hospital de ser necesario

- » Manténgase alerta para detectar situaciones que puedan requerir la derivación a un especialista o a un hospital, por ejemplo, la ausencia de respuesta al tratamiento, efectos secundarios graves de intervenciones farmacológicas, trastornos físicos o MNS concomitantes, y el riesgo de autolesión o suicidio.

5 Seguimiento

- » Organice una visita del paciente al consultorio para el seguimiento después de la evaluación inicial.
- » Después de cada visita, programe una cita para el seguimiento e insista en la importancia de la atención. Haga la cita para un momento que sea mutuamente conveniente.
- » **Programe visitas de seguimiento inicial con mayor frecuencia hasta que los síntomas empiecen a responder al tratamiento.** Una vez que los síntomas comiencen a mejorar, programe citas menos frecuentes pero periódicas.
- » **En cada sesión de seguimiento, evalúe:**
 - La respuesta al tratamiento, los efectos secundarios de la medicación y la observancia al tratamiento farmacológico y a las intervenciones psicosociales.
 - El estado general de salud (asegúrese de vigilar con regularidad el estado de salud física).
 - El autocuidado (por ejemplo, la alimentación, la higiene, la vestimenta) y el funcionamiento de la persona en su propio entorno.
 - Problemas psicosociales o cambios en las condiciones de vida que puedan afectar su manejo.
 - La comprensión y las expectativas del tratamiento por parte de la persona y del cuidador. Corrija cualquier idea errónea.

» Durante todo el período de seguimiento:

- Reconozca todo progreso hacia las metas del tratamiento y refuerce el cumplimiento de la terapia.
- Mantenga un contacto periódico con la persona (y con

su cuidador, cuando corresponda). Si es factible, asigne a un trabajador de la comunidad u otra persona confiable de la comunidad (por ejemplo, un familiar) para que apoye a la persona.

—Explique que la persona puede regresar al consultorio en cualquier momento entre las visitas de seguimiento de ser necesario (por ejemplo, cuando hay efectos secundarios de medicamentos, etc.).

—Tenga un plan de acción para cuando la persona no asista a las citas.

—Use recursos de la familia y la comunidad para comunicarse con las personas que no han regresado para el seguimiento periódico.

—Consulte a un especialista si la persona no mejora o empeora.

—Documente los aspectos clave de las interacciones con la persona y la familia en las notas sobre el caso.

» Vaya a la sección de “Manejo” del módulo o los módulos pertinentes para información sobre el seguimiento específico del trastorno.

6 Participación de los cuidadores

- » Cuando sea apropiado y con el consentimiento de la persona tratada, incluya al cuidador o a un familiar en la atención de la persona.
- » Reconozca que puede ser difícil cuidar a personas con trastornos MNS.
- » Explique al cuidador la importancia de respetar la dignidad y los derechos de la persona con un trastorno MNS.
- » Identifique las repercusiones psicosociales para los cuidadores.
- » Determine las necesidades del cuidador a fin de garantizar el apoyo y los recursos necesarios para la vida familiar, el empleo, las actividades sociales y la salud.
- » Promueva la participación en grupos de autoayuda y de apoyo familiar, cuando existan.
- » Con el consentimiento de la persona, mantenga a los cuidadores informados acerca del estado de salud de la persona, incluidos temas relacionados con la evaluación, el tratamiento, el seguimiento y cualquier posible efecto colateral.

7 Enlaces con otros sectores

- » Para garantizar una atención integral y basada en la evaluación inicial, vincule a la persona con servicios de empleo y de educación, y con servicios sociales (incluidos los concernientes a la vivienda) y otros sectores pertinentes.

8 Grupos de población especiales



NIÑOS Y ADOLESCENTES

- » Investigue una posible exposición a factores adversos, como la violencia y el descuido, que puedan afectar la salud mental y el bienestar.
- » Evalúe las necesidades de los cuidadores.
- » Trate a los adolescentes que pudieran venir solos para conseguir ayuda, aunque no estén acompañados por padres o tutores. Obtenga el consentimiento fundamentado del adolescente.
- » Brinde oportunidades al niño o al adolescente para que expresen sus inquietudes en privado.
- » Adapte su lenguaje al nivel de comprensión del niño o el adolescente.
- » Indague acerca de los recursos disponibles dentro de la familia, la escuela y la comunidad.



MUJERES DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA

- » Si la mujer está en edad fecunda, pregunte:
 - si está amamantando,
 - si está embarazada y,
 - si está embarazada, cuándo menstruó por última vez.
- » Sirva de enlace con el especialista en salud materna para organizar la atención.
- » Considere la consulta con un especialista en salud mental, si lo hay.
- » Obre con cautela con las intervenciones farmacológicas; verifique la toxicidad para el feto y el traspaso de fármacos

a la leche materna. Consulte a un especialista según sea necesario.



ADULTOS MAYORES

- » Aborde los factores psicosociales estresantes que son particularmente pertinentes para la persona, respetando su necesidad de autonomía.
- » Determine y trate los problemas de salud física concurrentes y aborde los déficits sensoriales (como la disminución de la agudeza visual o la audición deficiente) con dispositivos apropiados (por ejemplo, una lupa, audífonos).
- » Use dosis inferiores de los medicamentos.
- » Prevea un mayor riesgo de interacciones medicamentosas.
- » Aborde las necesidades de los cuidadores.

DEPRESIÓN

Las personas que sufren depresión experimentan una variedad de síntomas, como un estado de ánimo deprimido persistente o pérdida de interés y placer durante al menos dos semanas.

Como se describe en este módulo, las personas con depresión tienen considerables dificultades en su funcionamiento cotidiano en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo.

Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad y síntomas somáticos sin explicación médica discernible.

La depresión generalmente se presenta junto con otros trastornos MNS así como con enfermedades físicas.

El manejo de síntomas que no satisfagan plenamente los criterios para clasificar el trastorno como depresión es abordado en el módulo Otros padecimientos de salud mental importantes. Vaya al módulo OTR.

DEP » Panorama breve



EVALUACIÓN

- » ¿Sufre la persona depresión?
- » ¿Hay otras explicaciones para los síntomas?
 - Descarte posibles trastornos físicos.
 - Descarte la existencia de antecedentes de manía.
 - Descarte reacciones normales a una pérdida importante reciente.
- » Investigue otros trastornos MNS prioritarios.



MANEJO

- » Protocolos de manejo
 1. Depresión
 2. Episodio depresivo en el trastorno bipolar
 3. Grupos especiales de población
- »  Intervenciones psicosociales
- »  Intervenciones farmacológicas



SEGUIMIENTO



DEP 1 » Evaluación

MANIFESTACIONES COMUNES DE LA DEPRESIÓN

- *Múltiples síntomas físicos persistentes sin causa clara*
- *Escasa energía, fatiga, alteraciones del sueño*
- *Tristeza o estado de ánimo deprimido persistentes, ansiedad*
- *Pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras*

1

¿Tiene la persona depresión?

¿Ha tenido la persona al menos uno de los siguientes síntomas básicos de la depresión durante al menos dos semanas?

- Estado de ánimo deprimido persistente
- Marcada disminución del interés o el placer en realizar actividades antes disfrutadas

NO

SÍ

Es improbable que sea depresión

» Vaya al módulo »OTR

¿Tiene o tuvo la persona varios de los otros síntomas siguientes durante al menos dos semanas?

- Alteraciones del sueño o dormir demasiado
- Cambio significativo del apetito o el peso (disminución o aumento)
- Creencia de que carece de méritos o de una culpabilidad excesiva
- Fatiga o pérdida de energía
- Disminución de la concentración
- Indecisión
- Agitación observable o inquietud física
- Habla o se mueve más lentamente de lo usual
- Desesperanza
- Pensamientos o actos suicidas

NO

SÍ

Es improbable que sea depresión

» Vaya al módulo »OTR

¿Tiene la persona considerable dificultad en el funcionamiento diario en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo?

NO

SÍ

Es improbable que sea depresión

» Vaya al módulo »OTR

Considere la posible existencia de DEPRESIÓN

CONSEJO CLÍNICO:

Una persona con depresión puede tener síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones. Si están presentes estos síntomas, se debe adaptar el tratamiento para la depresión. **CONSULTE A UN ESPECIALISTA.** 



2

¿Hay otras explicaciones posibles de los síntomas?

¿ES UNA ENFERMEDAD FÍSICA QUE PUEDE ASEMEJARSE A LA DEPRESIÓN O EXACERBARLA?
¿Hay signos y síntomas que sugieran la presencia de anemia, desnutrición, hipotiroidismo, alteraciones del estado de ánimo por el consumo de sustancias y efectos secundarios de medicamentos (por ejemplo, alteraciones del estado de ánimo por el consumo de esteroides)?

» TRATE
LA ENFERMEDAD FÍSICA

SÍ

NO

¿Persisten los síntomas depresivos después del tratamiento?

NO

SÍ

No es necesario
ningún
tratamiento.

¿HAY ANTECEDENTES DE MANÍA?

¿Se han presentado simultáneamente varios de los siguientes síntomas, con una duración de al menos una semana y con una gravedad suficiente para interferir considerablemente con el trabajo y las actividades sociales o para requerir hospitalización o reclusión?

- Elevación del estado de ánimo o irritabilidad
- Disminución de la necesidad de sueño
- Mayor actividad, sentimiento de mayor energía, la persona habla en demasía o con gran rapidez
- Comportamientos impulsivos o imprudentes, como gastar dinero excesivamente, tomar decisiones importantes sin reflexionar y cometer indiscreciones sexuales
- Pérdida de inhibiciones sociales normales que da lugar a comportamientos inapropiados
- Se distrae fácilmente
- Muestra una autoestima exacerbada sin una justificación real

NO

SÍ

Es probable que sea un
**EPISODIO DEPRESIVO EN
EL TRASTORNO BIPOLAR**



CONSEJO CLÍNICO:

Las personas con un episodio depresivo en el trastorno bipolar corren el riesgo de padecer manía. El tratamiento es diferente del usado para la depresión. **Se debe aplicar el PROTOCOLO 2.**

» Vaya al **PASO 3** y luego **PROTOCOLO 2**

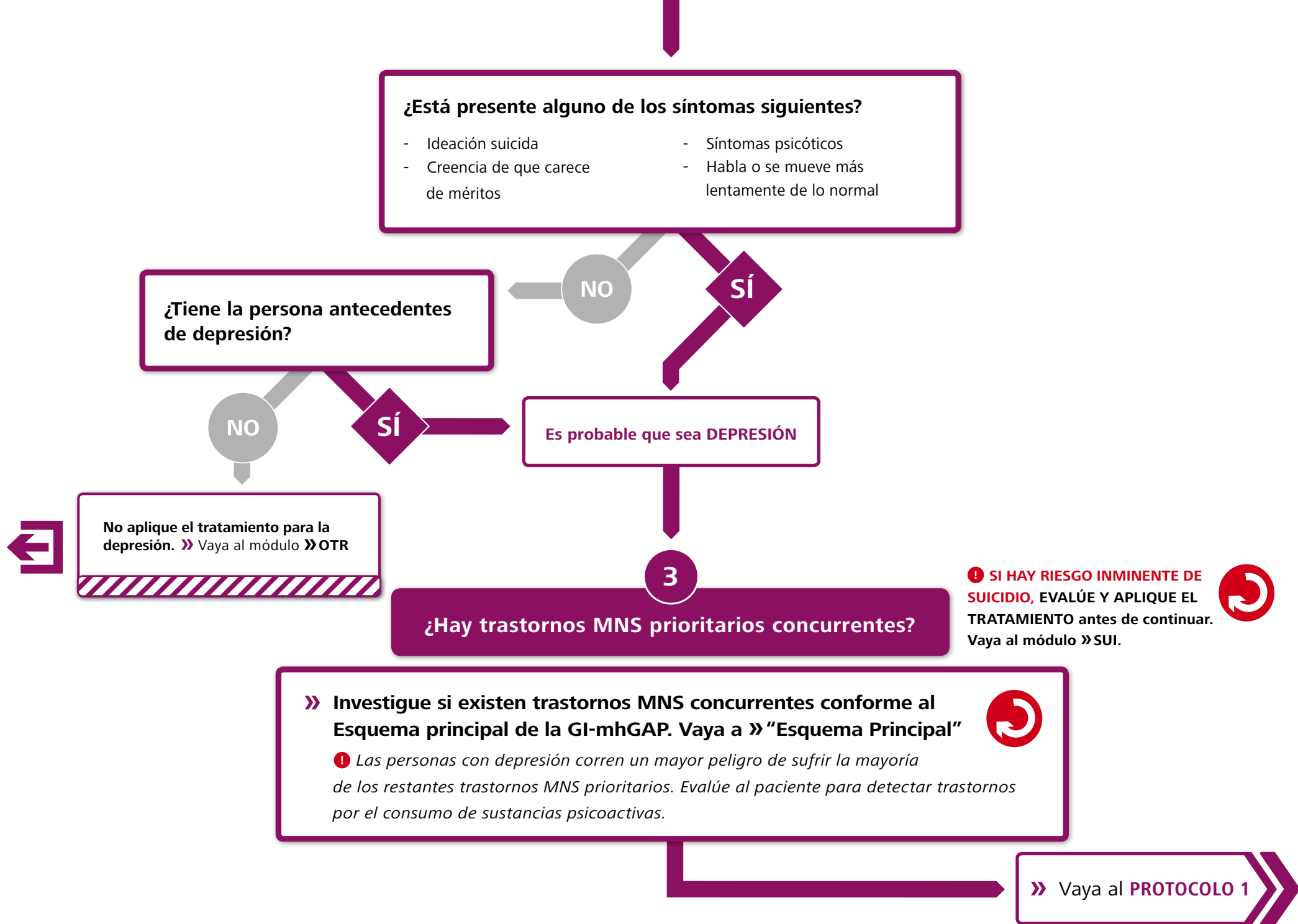
¿HA SUFRIDO UNA PÉRDIDA IMPORTANTE (POR EJEMPLO, DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE UN ALLEGADO) DENTRO DE LOS SEIS ÚLTIMOS MESES?

SÍ

NO

Es probable que sea **DEPRESIÓN**

» Vaya al **PASO 3** y luego **PROTOCOLO 1**





DEP 2 » Manejo

PROTOCOLO

1

Depresión

- » Proporcione psicoeducación a la persona y a sus cuidadores. (2.1)
- » Reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. (2.2)
- » Promueva el funcionamiento adecuado en las actividades diarias y en la vida de la comunidad. (2.3)
- » Considere la administración de antidepresivos. (2.5)
- » Si es factible, considere la derivación del paciente para que reciba alguno de los siguientes tratamientos psicológicos breves: activación conductual, terapia cognitivo conductual, terapia interpersonal y orientación para la resolución de problemas. (2.4)
- » **NO** trate los síntomas con tratamientos ineficaces, por ejemplo, inyecciones de vitaminas.
- » Efectúe un seguimiento periódico.

PROTOCOLO

2

Depresión en el trastorno bipolar

- » Consulte a un especialista.
- » Si no dispone de inmediato de un especialista, continúe el tratamiento para la depresión (**PROTOCOLO 1**). Sin embargo, NUNCA recete antidepresivos solos sin un estabilizador del estado de ánimo como el litio, la carbamazepina o el valproato porque los antidepresivos pueden conducir a la manía en personas con trastorno bipolar (Vaya al módulo » **PSI**).
- » Si se presentaran síntomas de manía, dígame a la persona y a los cuidadores que suspendan de inmediato el antidepresivo y regresen para recibir ayuda.

Grupos especiales de población

Observe que las intervenciones pueden diferir para estos grupos de población.



NIÑO/ADOLESCENTE

- » Para el tratamiento de la depresión en niños/adolescentes, vaya al módulo **» MCON**.



MUJERES DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA

- » Siga el tratamiento para la depresión (**PROTOCOLO 1**), pero EVITE usar antidepresivos si fuera posible, especialmente durante el primer trimestre.
- » Si la paciente no responde al tratamiento psicológico, considere la posibilidad de usar con precaución la dosis eficaz más baja de los antidepresivos.
- » Si la mujer está amamantando, evite los medicamentos de acción prolongada, como la fluoxetina.
- » CONSULTE A UN ESPECIALISTA, si es factible.

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES

2.1 Psicoeducación: mensajes fundamentales para la persona y los cuidadores

- » La depresión es un problema muy frecuente que le puede suceder a cualquier persona.
- » La aparición de la depresión no significa que la persona sea débil o perezosa.
- » Actitudes negativas de otras personas (por ejemplo, decirle “debes ser más fuerte”, “contrólate”) pueden obedecer a que la depresión no es una dolencia visible, a diferencia de una fractura o una herida. Existe también la idea errónea de que las personas con depresión pueden controlar fácilmente sus síntomas mediante la simple fuerza de voluntad.
- » Las personas con depresión tienden a tener opiniones negativas no realistas acerca de sí mismos, su vida y su futuro. Su situación actual puede ser muy difícil, pero la depresión puede causar pensamientos injustificados de desesperanza y falta de valor. Estas opiniones probablemente mejoren una vez que remita la depresión.
- » Los pensamientos de **autolesión o suicidio** son comunes. Si se detectan estos pensamientos, la persona no debe actuar para modificarlos sino que debe relatarlos a una persona de confianza y volver para pedir ayuda de inmediato.

2.2 Reduzca el estrés y fortalezca el apoyo social

- » Evalúe la existencia de factores estresantes y aplique el tratamiento para reducirlos. (Vaya al módulo » APE)
- » Reactive la red de relaciones sociales anteriores de la persona. Identifique actividades sociales previas que, si se comienzan nuevamente, en potencia pueden prestar apoyo psicosocial directo o indirecto, por ejemplo, las reuniones de familia, las visitas a vecinos y actividades de la comunidad.

2.3 Promueva el funcionamiento adecuado en las actividades diarias y en la vida de la comunidad

- » Aunque sea difícil, aliente a la persona a que trate de seguir tanto como sea posible las siguientes indicaciones:
 - Reanudar (o continuar) las actividades que fueron anteriormente placenteras.
 - Mantener un ciclo regular de horas para dormir y para estar despierto.
 - Mantenerse físicamente activo en la medida de lo posible.
 - Comer regularmente a pesar de las alteraciones del apetito.
 - Pasar tiempo con amigos de confianza y con la familia.
 - Participar en lo posible en las actividades comunitarias y otras actividades sociales.

- » Explique a la persona y al cuidador que estas actividades pueden todas ayudar a mejorar el estado de ánimo.

2.4 Tratamientos psicológicos breves para la depresión

- » Esta guía no proporciona protocolos específicos para llevar a cabo intervenciones psicológicas breves. La OMS, entre otros organismos, ha elaborado manuales que describen el uso de esas intervenciones para la depresión. Un ejemplo es el manual Problem Management Plus (http://www.who.int/mental_health/emergencies/problem_management_plus/en/, en inglés) que describe el uso de la activación conductual, técnicas de relajación, la orientación para la resolución de problemas y el fortalecimiento del apoyo social. Por otra parte el manual Group Interpersonal Therapy for Depression describe el tratamiento grupal de la depresión (http://www.who.int/mental_health/mhgap/interpersonal_therapy/en, en inglés). En Pensamiento saludable: Manual para la atención psicosocial de la depresión perinatal (http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28417/9789275318997_spa.pdf?sequence=18&isAllowed=y) se describe el uso de la terapia cognitivo conductual para la depresión perinatal.

INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS

2.5 Considere la posibilidad de administrar antidepresivos

- » Analice con la persona y decidan juntos si se recetarán antidepresivos. Explique que:
 - Los antidepresivos no causan adicción.
 - Es muy importante tomar la medicación todos los días como se le prescriba.
 - Se pueden experimentar algunos efectos secundarios en los primeros días, pero generalmente remiten en forma espontánea.
 - Por lo general pasan varias semanas antes de que se noten mejoras en el estado de ánimo, el interés o la energía.
- » Considere la edad de la persona, padecimientos médicos concurrentes y el perfil de efectos secundarios del medicamento.
- » Comience con un solo medicamento en la dosis inicial más baja.
- » Los medicamentos antidepresivos, en general, deben ser administrados durante al menos 9 a 12 meses después de la remisión de los síntomas.
- » Los medicamentos nunca se deben suspender solo porque la persona experimenta alguna mejoría. Instruya a la persona acerca del tiempo recomendado para tomar los medicamentos.

PRECAUCIONES

- » Si la persona sufre un episodio maníaco, suspenda el antidepresivo de inmediato; el medicamento antidepresivo puede desencadenar un episodio maníaco en el trastorno bipolar sin tratar.
- » No combine el medicamento con otros antidepresivos, ya que esto puede causar el síndrome de la serotonina.
- » Los antidepresivos pueden aumentar la ideación suicida, especialmente en los adolescentes y los adultos jóvenes.

Medicación antidepresiva en grupos especiales de población

ADOLESCENTES DE 12 AÑOS O MÁS

- » Si los síntomas persisten o empeoran a pesar de las intervenciones psicosociales, considere la posibilidad de administrar fluoxetina (pero ningún otro inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina [ISRS] ni antidepresivos tricíclicos [ATC]). 
- » Si se receta fluoxetina, pídale al adolescente que regrese semanalmente durante las cuatro primeras semanas para vigilar la aparición de pensamientos o planes de suicidio.

MUJERES DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA

- » Evite los antidepresivos, si es posible.
- » Considere la administración de antidepresivos en la dosis eficaz más baja si no hay ninguna respuesta a las intervenciones psicosociales.

- » Si la mujer está amamantando, evite medicación antidepresiva de acción prolongada como la fluoxetina.

- » Consulte a un especialista, si es factible. 

ADULTOS MAYORES

- » Evite recetar amitriptilina si es posible.

PERSONAS CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

- »  NO recete amitriptilina.

ADULTOS CON PENSAMIENTOS O PLANES DE SUICIDIO

- » Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son la primera opción. La sobredosis de un antidepresivo tricíclico como la amitriptilina puede ser mortal y, por consiguiente, se debe evitar en este grupo.
- » Si hay un riesgo inminente de autolesión o suicidio (vaya al módulo **SUI**), entregue una cantidad limitada de antidepresivos (por ejemplo, la provisión necesaria para una semana cada vez).
- » Pida a las personas que se ocupan de la persona que guarden y vigilen los medicamentos y efectúen su seguimiento con frecuencia para prevenir una sobredosis.

CUADRO 1: Antidepresivos

MEDICAMENTO	DOSIFICACIÓN	EFFECTOS SECUNDARIOS	CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES
AMITRIPTILINA (antidepresivo tricíclico [ATC])	Comience con 25 mg a la hora de acostarse. Aumente de 25-50 mg por semana a 100-150 mg por día (hasta 300 mg como máximo). Nota: La dosis eficaz mínima en los adultos es de 75 mg. Se puede ver sedación con dosis inferiores. Adultos mayores/personas con enfermedad física: Comience con 25 mg a la hora de acostarse y aumente a 50-75 mg diarios (hasta 100 mg como máximo).  Niños/adolescentes: No la use.	Comunes: sedación, hipotensión ortostática (riesgo de caída), visión borrosa, dificultad para orinar, náuseas, aumento de peso, disfunción sexual. Graves: alteraciones electrocardiográficas (por ejemplo, prolongación del intervalo QT), arritmia cardíaca, aumento del riesgo de padecer una crisis convulsiva.	Evite recetarla a personas con enfermedades cardíacas, antecedentes de crisis convulsivas, hipertiroidismo, retención urinaria o glaucoma de ángulo estrecho y trastorno bipolar (se puede desencadenar manía en personas con trastorno bipolar sin tratar). La sobredosis puede causar crisis convulsivas, arritmia cardíaca, hipotensión, coma o la muerte. Las concentraciones de amitriptilina pueden aumentar con los medicamentos antimaláricos, como la quinina.
FLUOXETINA (inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina [ISRS])	Comience con 10 mg por día durante una semana, luego aumente a 20 mg por día. Si no hay ninguna respuesta en 6 semanas, aumente a 40 mg (80 mg como máximo). Adultos mayores/personas con enfermedad física: es la opción preferida. Comience con 10 mg por día, luego aumente a 20 mg (40 mg como máximo).  Adolescentes Comience con 10 mg por día. Aumente a 20 mg por día si no hay respuesta en 6 semanas (40 mg como máximo).	Comunes: Sedación, insomnio, cefalea, mareos, molestias gastrointestinales, alteración del apetito y disfunción sexual. Graves: alteraciones de la coagulación en las personas que usan aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, niveles bajos de sodio.	Tome precauciones cuando se trata de personas con antecedentes de crisis convulsivas. Interacciones medicamentosas: Evite la combinación con warfarina (puede aumentar el riesgo de hemorragias). Pueden aumentar las concentraciones de ATC, antipsicóticos y betabloqueadores. Tome precauciones cuando se usa en combinación con tamoxifeno, codeína y tramadol (reduce el efecto de estos medicamentos).

DEP 3 » Seguimiento

1

EVALUACIÓN PARA DETERMINAR
SI HAY MEJORÍA

¿Está mejorando la persona?

NO

SÍ

- » Si no todavía no recibe tratamiento psicológico, considere la posibilidad de ese tratamiento.
- » Si recibe un tratamiento psicológico, evalúe la participación de la persona y su experiencia con el tratamiento psicológico actual.
- » Si todavía no es tratada con antidepresivos, considere recetar antidepresivos.
- » Si está en tratamiento con antidepresivos, investigue:
 - ¿Toma la persona la medicación como se le ha prescrito?
Si no lo hace, indague acerca de las razones y promueva el cumplimiento del tratamiento.
 - ¿Presenta efectos secundarios?

En caso afirmativo, evalúe y sopesa los beneficios del tratamiento.

En caso negativo, aumente la dosis (CUADRO 1). Efectúe el seguimiento en una o dos semanas.

Follow-up in 1-2 weeks. 

⚠ TOME PRECAUCIONES CON EL AUMENTO DE LA DOSIS.
SE REQUIERE UN SEGUIMIENTO MUY DE CERCA DEBIDO AL POSIBLE AUMENTO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS.

- » Aliente a la persona a continuar con su plan de tratamiento actual hasta que esté libre de los síntomas durante un período de 9 a 12 meses.

- » Organice otra cita de seguimiento para una o dos semanas después. 

- » Reduzca el contacto a medida que mejoren los síntomas de la persona, por ejemplo, véala una vez cada 3 meses después de los 3 meses iniciales.

Nota: El seguimiento debe continuar hasta que la persona ya no tenga ningún síntoma de depresión.

RECOMENDACIONES SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTACTO

- » Haga la segunda cita para no más de una semana después.
- » Mantenga inicialmente un contacto periódico por teléfono, mediante visitas a domicilio, cartas o tarjetas de contacto con mayor frecuencia, por ejemplo, mensualmente, durante los 3 primeros meses.



¿Hay síntomas de manía?

SÍ

NO

- » Descontinúe la medicación antidepresiva.
 - » Trate la manía y consulte a un especialista.
- Vaya al módulo PSI. 

2

MONITOREE EL TRATAMIENTO

En cada contacto:

- » Proporcione psicoeducación, reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales, promueva el funcionamiento adecuado en las actividades diarias y en la vida de la comunidad y examine, si procede, el uso de medicamentos antidepresivos y el tratamiento psicológico.
 - » ¿Tiene la persona algún síntoma que cause inquietud? Examine a la persona para detectar trastornos médicos concurrentes.
 - » ¿Es la persona una mujer en edad fértil que piensa embarazarse? En caso afirmativo, CONSULTE A UN ESPECIALISTA. 
- ❗ Investigue si hay RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO (vaya al módulo »SUI).

3

REVISE EL TRATAMIENTO SI PROCEDE

¿Ha estado la persona libre de síntomas durante un período de 9 a 12 meses?

NO

SÍ

- » Continúe la medicación hasta que la persona esté libre de síntomas durante 9 a 12 meses.

- » Analice con la persona los riesgos y los beneficios de suspender la medicación.
- » Disminuya gradualmente la dosis de la medicación durante un mínimo de 4 semanas. Vigile a la persona para detectar una posible recurrencia de los síntomas.

PSICOSIS

El módulo sobre las psicosis abarca el manejo de dos trastornos de salud mental: las psicosis y los trastornos bipolares. Las personas con alguna psicosis o trastorno bipolar corren un alto riesgo de estar expuestas a la estigmatización, la discriminación y la violación de su derecho a vivir con dignidad.

Las psicosis se caracterizan por la distorsión del pensamiento y de la percepción y por la perturbación de las emociones y los comportamientos. La persona también puede presentar un lenguaje incoherente o ilógico. Además, se pueden detectar síntomas como alucinaciones (escuchar voces o ver cosas que no existen); estados delirantes (creencias falsas fijas); anormalidades graves de la conducta (comportamiento desorganizado, agitación, excitación, inactividad o hiperactividad); alteraciones de las emociones (apatía pronunciada o incoherencia entre la emoción que la persona señala y la que se observa en la expresión facial y el lenguaje corporal).

Los trastornos bipolares se caracterizan por episodios en los cuales el estado de ánimo y los niveles de actividad de la persona están significativamente alterados. En algunas ocasiones consiste en una elevación del estado de ánimo y un aumento de la energía y la actividad (manía) y, en otros casos, en una caída del estado de ánimo y una reducción de la energía y la actividad (depresión). Generalmente, la recuperación es completa entre un episodio y otro. Las personas que solo experimentan episodios maníacos también se incluyen en la categoría de los trastornos bipolares.

PSI » Panorama breve



EVALUACIÓN

» Investigue otras explicaciones de los síntomas.

— INVESTIGUE SI HAY TRASTORNOS MÉDICOS

por ejemplo, descarte el delirio, los medicamentos y anomalías metabólicas.

— INVESTIGUE SI EXISTEN OTROS TRASTORNOS MNS PERTINENTES.

» Determine si hay episodios maníacos agudos.

» Evalúe la posibilidad de que la persona sufra psicosis



MANEJO

» Protocolos de manejo

1. Trastorno bipolar, episodio maníaco
2. Psicosis
3. Grupos especiales de población: mujeres durante el embarazo o la lactancia, adolescentes y adultos mayores

» Intervenciones psicosociales

» Intervenciones farmacológicas

1. Psicosis: iniciación de la medicación con antipsicóticos
2. Episodio maníaco: iniciación de la medicación estabilizadora del estado de ánimo o antipsicótica; evite los antidepresivos



SEGUIMIENTO



PSI 1 » Evaluación

MANIFESTACIONES COMUNES DE LAS PSICOSIS

- Cambios pronunciados de la conducta, descuido de las responsabilidades habituales relacionadas con el trabajo, la escuela, las actividades domésticas o sociales.
- Comportamiento agitado, agresivo; aumento o disminución de la actividad
- Creencias falsas fijas no compartidas por otros en la cultura de la persona.
- Oye voces o ve cosas que no existen.
- No se da cuenta que tiene problemas de salud mental.

1

¿Hay otras explicaciones para los síntomas?

» EVALÚE SI EXISTEN TRASTORNOS FÍSICOS

De acuerdo con la historia clínica, el examen clínico o los resultados de laboratorio, ¿hay signos y síntomas que indiquen **delirio** debido a una enfermedad física aguda, por ejemplo, infección, malaria cerebral, deshidratación, anomalías metabólicas (como hipoglucemia o hponatremia), o **efectos secundarios de la medicación**, por ejemplo, a causa de algún medicamento antimalárico o esteroideo?

» Evalúe y trate la enfermedad física aguda y **derive al paciente a servicios de urgencia o a un especialista según sea necesario.**

» Si los síntomas persisten después del tratamiento de la causa aguda, vaya al **PASO 2**

SÍ

NO

» EVALÚE PARA DETERMINAR SI SE TRATA DE DEMENCIA, DEPRESIÓN, INTOXICACIÓN O ABSTINENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL.

» Considere efectuar una consulta con un especialista en salud mental para el tratamiento de los trastornos concurrentes. 

» Trate los trastornos concurrentes.
Vaya a los módulos pertinentes.

SÍ

NO

MANEJO DE LA AGITACIÓN AGUDA O LA AGRESIÓN

Si la persona presenta agitación aguda o agresividad aguda:

» Vaya al cuadro "Manejo de las personas con conducta agitada o agresiva" (**Cuadro 5**) en este módulo antes de proseguir.

2

¿Está teniendo la persona un episodio maníaco agudo?

¿Se han presentado simultáneamente varios de los síntomas mencionados a continuación y han durado al menos una semana con gravedad suficiente para interferir considerablemente en el trabajo y las actividades sociales o requerir reclusión u hospitalización?

— Estado de ánimo elevado o irritable
— Disminución de la necesidad de sueño
— Aumento de la actividad, sentimiento de mayor energía, habla mucho o con rapidez

— Pérdida de inhibiciones sociales normales, como indiscreciones sexuales
— Comportamientos impulsivos o temerarios, como gastos de dinero

excesivos, toma de decisiones importantes sin reflexionar
— Se distrae fácilmente
— Aumento injustificado de la autoestima

NO

SÍ

Sospeche que hay un episodio maníaco del **TRASTORNO BIPOLAR**

CONSEJO CLÍNICO: Las personas con trastorno bipolar pueden experimentar a lo largo de su vida solo episodios maníacos o una combinación de episodios maníacos y depresivos.

» Para aprender a evaluar y controlar el episodio depresivo del trastorno bipolar, vaya al módulo »DEP.

! SI HAY RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO, EVALÚELO Y TRÁTELO antes de proseguir. Vaya al módulo »SUI.



» Vaya al **PROTOCOLO 1**



3

¿Sufre la persona de psicosis?

¿Tiene la persona al menos dos de los síntomas siguientes?

- Estados delirantes, creencias fijas falsas no compartidas por otros en la cultura de la persona
- Alucinaciones, oye voces o ve cosas que no existen
- Lenguaje o conducta desorganizados, por ejemplo, habla incoherente o ilógicamente, como murmurar o reírse solo, apariencia extraña, signos de descuido de sí mismo o apariencia descuidada

NO

SÍ

» Considere la necesidad de consultar a un especialista para examinar otras causas posibles de psicosis. 

Sospeche que se trata de un caso de PSICOSIS

» Vaya al **PROTOCOLO 2**

! SI HAY RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO, EVALÚELO Y TRÁTELO antes de proseguir. Vaya al módulo »SUI.





PSI 2 » Manejo

PROTOCOLO

1

Episodio maníaco en el trastorno bipolar

- » Proporcione **psicoeducación** a la persona y los cuidadores. (2.1)
- » **Intervención farmacológica.** (2.6)
- ❗ **Si el paciente está siendo tratado con antidepresivos, DESCONTINÚE la medicación** para prevenir un mayor riesgo de manía.
- **Empiece el tratamiento** con litio, valproato, carbamazepina o antipsicóticos. Considere usar benzodiazepina a corto plazo (2 a 4 semanas como máximo) para el trastorno conductual o la agitación.
- » Promueva el funcionamiento adecuado en las actividades diarias. (2.3)
- » Garantice la seguridad de la persona y la seguridad de otros
- » Efectúe un seguimiento periódico.
- » Apoye la rehabilitación en la comunidad.
- » Reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. (2.2)

PROTOCOLO

2

Psicosis

- » Proporcione **psicoeducación** a la persona y a los cuidadores. (2.1)
- » **Empiece la medicación antipsicótica.** (2.5)
- Comience con una dosis baja dentro del margen terapéutico y aumentela lentamente hasta alcanzar la dosis eficaz más baja, a fin de reducir el riesgo de padecer efectos secundarios.
- » Promueva el funcionamiento adecuado en las actividades diarias. (2.3)
- » Garantice la seguridad de la persona y la seguridad de otros.
- » Efectúe un seguimiento periódico.
- » Apoye la rehabilitación en la comunidad.
- » Reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. (2.2)

Grupos especiales de población

Observe que las intervenciones para la PSICOSIS pueden diferir en estos grupos de población.



MUJERES DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA

- » Sirva de enlace con especialistas en salud materna para organizar la atención.
- » Considere la consulta con un especialista en salud mental si es factible.
- » Explique el riesgo de consecuencias adversas para la madre y su bebé, incluidas complicaciones obstétricas y recaídas psicóticas, en particular si se suspendió la medicación.
- » Considere una intervención farmacológica cuando sea apropiado y disponga de ella. Vea las indicaciones a continuación.

Intervenciones farmacológicas: PSICOSIS

- » En las mujeres con psicosis que están planificando un embarazo, ya están embarazadas o que amamantan, se puede considerar recetar haloperidol por vía oral en dosis bajas, o clorpromazina.
- » **NO** se deben prescribir anticolinérgicos a las mujeres que están embarazadas debido a los efectos secundarios extrapiramidales de los medicamentos antipsicóticos, excepto en los casos agudos, a corto plazo.
- » No se deben recetar sistemáticamente antipsicóticos de depósito (de efecto retardado) a las mujeres con trastornos psicóticos que están planificando un embarazo, están embarazadas o amamantan, porque hay relativamente poca información sobre su seguridad en este grupo de población.

EPISODIO MANÍACO EN EL TRASTORNO BIPOLAR

- » **EVITE USAR VALPROATO, LITIO y CARBAMAZEPINA** durante el embarazo y la lactancia materna debido al riesgo de que se produzcan malformaciones congénitas.
- » Considere el empleo de **haloperidol en dosis bajas** con precaución y en consulta con un especialista, si es factible.
- » Sopesen los riesgos y los beneficios de los medicamentos en las mujeres en edad fértil.
- » Si en una embarazada se presenta manía aguda mientras toma estabilizadores del estado de ánimo, considere la posibilidad de cambiar a haloperidol en dosis bajas.



ADOLESCENTES

- » Considere la consulta con un especialista en salud mental.
- » En los adolescentes con trastorno psicótico o bipolar, se puede recetar **risperidona** como una opción de tratamiento solo bajo la supervisión de un especialista.
- » Si el tratamiento con risperidona no es factible, se puede usar **haloperidol o clorpromazina** solo bajo la supervisión de un especialista.



ADULTOS MAYORES

- » Use dosis **inferiores** de la medicación.
- » Prevea un mayor riesgo de interacciones medicamentosas.
- » **PRECAUCIONES**
Los antipsicóticos conllevan un mayor riesgo de episodios cerebrovasculares y muerte en los adultos mayores con psicosis relacionada con demencia.

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES

2.1 Psicoeducación

Mensajes clave para la persona y sus cuidadores:

- » Explique que los síntomas se deben a un trastorno de salud mental, que la psicosis y los trastornos bipolares pueden ser tratados y que la persona puede recuperarse. Aclare las ideas erróneas comunes acerca de la psicosis y el trastorno bipolar.
- »  No culpe a la persona o a su familia ni los acuse de ser la causa de los síntomas.
- » Señale a la persona y a la familia que la persona tiene que tomar los medicamentos prescritos y regresar para el seguimiento periódicamente.
- » Explique que la reaparición o el empeoramiento de los síntomas son comunes y que es importante reconocerlos tempranamente y concurrir al establecimiento de salud cuanto antes.
- » Planifique un calendario sistemático de trabajo o actividades escolares que **evite la privación del sueño y el estrés** tanto a la persona como a los cuidadores. Aliente a la persona a solicitar consejos en relación con decisiones importantes, especialmente las concernientes a dinero o compromisos esenciales.
- » Recomiende **evitar el consumo de alcohol, cannabis u**

otras drogas no recetadas, ya que pueden empeorar los síntomas psicóticos o bipolares.

- » Informe a la persona sobre cómo mantener un modo de vida saludable, por ejemplo, una alimentación equilibrada, actividad física, sueño regular, buena higiene personal y ningún factor estresante. El estrés puede empeorar los síntomas psicóticos. *Nota: Los cambios del modo de vida deben continuar tanto tiempo como sea necesario, posiblemente de manera indefinida. Estos cambios se deben planificar y llevar a cabo de tal modo que se logre su sostenibilidad.*

2.2 Reducir el estrés y fortalecer los apoyos sociales

- » Establezca la coordinación con las instancias sanitarias y sociales disponibles para satisfacer las necesidades de salud física, social y mental de la familia.
- » Determine las actividades sociales previas de la persona que, de reiniciarse, tendrían el potencial de prestarle apoyo psicológico y social directo o indirecto; por ejemplo, reuniones de familia, salidas con amigos, visitas a vecinos, actividades sociales en el lugar de trabajo, deportes y actividades de la comunidad. Aliente a la persona a que reanude estas actividades sociales y asesore a los familiares acerca de esto.
- » Aliente a la persona y a los cuidadores a que mejoren los sistemas de apoyo social.

2.3 Promover el funcionamiento adecuado en las actividades cotidianas de la vida

- » Haga que la persona continúe en la medida de lo posible sus actividades sociales, educativas y ocupacionales habituales. Es mejor para la persona tener un trabajo o estar ocupado en otras cosas importantes.
- » Facilite la inclusión de la persona en actividades económicas, como el empleo con apoyo culturalmente apropiado.
- » Brinde a la persona capacitación en aptitudes para la vida o aptitudes sociales que mejoren las habilidades para la vida independiente de las personas con psicosis y trastorno bipolar y las de sus familias o cuidadores.
- » Facilite, si es factible y necesario, una vida independiente y una vivienda con apoyo que sea cultural y contextualmente apropiada en la comunidad.

2.4 Consejos generales para los cuidadores

- »  No trate de convencer a la persona de que sus creencias o experiencias son falsas o irreales. Trate de ser neutral y prestar apoyo, aun cuando la persona muestre una conducta extraña.
- »  Evite expresar críticas u hostilidad severas o constantes hacia la persona con psicosis
- » De a la persona libertad de movimiento. Evite restringirla y también garantice su seguridad básica y la de otras personas.
- » En general es mejor que la persona viva con su familia o miembros de la comunidad en un entorno propicio, fuera del entorno hospitalario. Se debe evitar la hospitalización a largo plazo.



CONSEJO CLÍNICO Establezca una relación de armonía con la persona.

La confianza mutua entre la persona y el prestador de atención de salud es fundamental para garantizar la observancia terapéutica y los resultados a largo plazo.



CONSEJO CLÍNICO

Garantice que las personas con psicosis sean tratadas con respeto y dignidad. Para mayores detalles vaya al módulo **» APE.**

2.5 Psicosis

- » Se debe recetar sistemáticamente antipsicóticos a una persona con psicosis.
- » **Comience la medicación antipsicótica de inmediato.** Vea **Cuadro 1**.
- » Recete solo un antipsicótico a la vez.
- » Comience con la dosis más baja y aumente gradual y lentamente la dosis para reducir el riesgo de efectos secundarios.
- » Pruebe la medicación en **una dosis normalmente eficaz por al menos 4 a 6 semanas** antes de considerarla ineficaz.
- » Siga vigilando esa dosis con la mayor frecuencia posible y según sea necesario durante las 4 a 6 primeras semanas de tratamiento. Si no hay ninguna mejoría, vea el **Seguimiento** y el **Cuadro 4**. 
- » Vigile, si es posible, el peso, la presión arterial, el azúcar en ayunas, el colesterol y el ECG en las personas con medicación antipsicótica (vea las indicaciones a continuación).

! PRECAUCIONES

» **Observe si se presentan los siguientes efectos secundarios:**

- **Efectos secundarios extrapiramidales:** acatisia, reacciones distónicas agudas, temblor, respiración en rueda dentada, rigidez muscular y discinesia tardía. Trate con medicamentos anticolinérgicos cuando estén indicados y disponibles (vea el Cuadro 2).
- **Cambios metabólicos:** aumento de peso, hipertensión, glucemia y colesterol elevados.
- **Cambios electrocardiográficos (intervalo QT prolongado):** monitoree los ECG si es posible.
- **Síndrome neuroléptico maligno:** un trastorno raro y potencialmente mortal caracterizado por la rigidez muscular, la temperatura elevada y la hipertensión.

2.6 Episodio maníaco en el trastorno bipolar

Si el paciente está en tratamiento con antidepresivos:

- » **DESCONTINUAR LOS ANTIDEPRESIVOS** para prevenir un riesgo mayor de padecer manía.
- » **Empezar el tratamiento con litio, valproato, carbamazepina o con antipsicóticos** (vea el **Cuadro 3**).

Litio: considere la posibilidad de usar litio como tratamiento de primera línea del trastorno bipolar solo si es factible el seguimiento clínico y de laboratorio y prescriba el litio solo con la supervisión de especialistas. Si no son factibles los exámenes de laboratorio, hay que evitar el litio y se debe considerar la administración de valproato o carbamazepina. Si es imprevisible el cumplimiento del tratamiento con litio o este puede ser interrumpido repentinamente, puede aumentar el riesgo de recaída. No prescriba litio cuando el abastecimiento del medicamento puede ser interrumpido con frecuencia. Si es factible, obtenga estudios de la función renal y tiroidea, pruebas de recuento sanguíneo completo, ECG y pruebas de embarazo antes de empezar el tratamiento.

Valproato y carbamazepina: Considere recetar estos medicamentos si no es factible el seguimiento clínico o de laboratorio para el litio o si no se dispone de un especialista para supervisar la prescripción de litio.

Haloperidol y risperidona: considere recetar haloperidol y risperidona solo si no es factible ningún seguimiento clínico o de laboratorio para comenzar la administración de litio o valproato. La risperidona se puede usar como una opción al haloperidol en las personas con manía bipolar si se puede garantizar la disponibilidad del medicamento y su costo no es una limitación.

! PRECAUCIONES

-  En el caso de las mujeres durante el embarazo o la lactancia, evite recetar valproato, litio y carbamazepina. Se recomienda usar **haloperidol** en dosis bajas, con precaución y bajo la supervisión de un especialista, si es factible.
- » **Considere administrar benzodiazepina a corto plazo (2 a 4 semanas como máximo) para los trastornos conductuales o la agitación:**
 - Las personas con manía que están experimentando agitación pueden beneficiarse con el uso a corto plazo (2 a 4 semanas como máximo) de una benzodiazepina, como el diazepam.
 - Se deben discontinuar gradualmente las benzodiazepinas tan pronto como mejoren los síntomas, ya que se puede desarrollar tolerancia.
- » Continúe el tratamiento de mantenimiento por al menos 2 años después del último episodio bipolar. 
 - Se puede dar litio o valproato para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar. Si el tratamiento con uno de estos agentes no es factible, se pueden usar haloperidol, clorpromazina o carbamazepina. **Brinde tratamiento de mantenimiento en los entornos de atención primaria bajo la supervisión de especialistas.**

CUADRO 1: Medicamentos antipsicóticos

MEDICACIÓN	DOSING	SIDE EFFECTS	CONTRAINDICATIONS/CAUTIONS
HALOPERIDOL	Comience con 1,5-3 mg/día. Aumente según sea necesario (hasta 20 mg/día como máximo). Vía de administración: oral o intramuscular (i.m.).	Comunes: sedación, mareo, visión borrosa, sensación de sequedad en la boca, retención urinaria, estreñimiento. Graves: hipotensión ortostática, efectos secundarios extrapiramidales, alteraciones electrocardiográficas (intervalo QT prolongado), aumento de peso, galactorrea, amenorrea, síndrome neuroléptico maligno.	Precaución en los pacientes con: enfermedades renales, hepatopatías, cardiopatías, síndrome del intervalo QT prolongado o que toman medicamentos que prolongan el intervalo QT. Monitoree los ECG si es posible.
RISPERIDONA	Comience con 1 mg/día. Aumente a 2-6 mg/día (hasta 10 mg como máximo). Vía de administración: oral.	Comunes: sedación, mareo, taquicardia. Graves: hipotensión ortostática, efectos metabólicos (aumento de lípidos, resistencia a la insulina, aumento de peso), efectos secundarios extrapiramidales, prolactina elevada, disfunción sexual, síndrome neuroléptico maligno.	Precaución en los pacientes con: cardiopatías. Interacciones medicamentosas: la carbamazepina puede reducir los niveles de risperidona, mientras que la fluoxetina puede aumentar esos niveles.
CLORPROMAZINA	Comience con 25-50 mg/día. Aumente a 75-300 mg/día (hasta 1.000 mg pueden ser necesarios en los casos graves). Vía de administración: oral.	Comunes: sedación, mareo, visión borrosa, sensación de sequedad en la boca, retención urinaria, estreñimiento, taquicardia. Graves: hipotensión ortostática, síncope, efectos secundarios extrapiramidales, fotosensibilidad, aumento de peso, galactorrea, amenorrea, disfunción sexual, priapismo, síndrome neuroléptico maligno, agranulocitosis, ictericia.	Contraindicaciones: pérdida de conciencia, depresión de la médula ósea, feocromocitoma. Precaución en los pacientes con: enfermedades respiratorias, enfermedades renales, hepatopatías, glaucoma, retención urinaria, cardiopatías, síndrome del intervalo QT prolongado o que toman medicamentos que prolongan el intervalo QT. Monitoree los ECG si es posible. Interacciones medicamentosas: — Aumenta los efectos de los medicamentos para disminuir la presión arterial. — Baja la presión arterial si se combina con la epinefrina. — Los niveles en sangre pueden ser mayores cuando se toman medicamentos antimaláricos como la quinina.
FLUFENAZINA de depósito/de acción prolongada	Comience con 12,5 mg. Use 12,5-50 mg cada 2-4 semanas. Vía de administración: i.m. en la región glútea  Evite usarla en las mujeres durante el embarazo o la lactancia.  No la use en niños o adolescentes.	Comunes: sedación, mareo, visión borrosa, sensación de sequedad en la boca, retención urinaria, estreñimiento, taquicardia. Graves: hipotensión ortostática, síncope, efectos secundarios extrapiramidales, fotosensibilidad, aumento de peso, galactorrea, amenorrea, disfunción sexual, priapismo, síndrome neuroléptico maligno, agranulocitosis, ictericia.	Contraindicaciones: pérdida de conciencia, parkinsonismo. Precaución en los pacientes con: cardiopatías, enfermedades renales, hepatopatías. Úsela con cuidado en los adultos mayores. Interacciones medicamentosas: — Aumenta los efectos de los medicamentos hipotensores. — Puede bajar la presión arterial si se usa junto con epinefrina.

CUADRO 2: Medicamentos anticolinérgicos

(para el tratamiento de efectos secundarios extrapiramidales)  Si es posible, evite usarlos en mujeres durante el embarazo o la lactancia.

MEDICACIÓN	DOSIFICACIÓN	EFFECTOS SECUNDARIOS	CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES
BIPERIDENO	Comience con 1mg dos veces al día. Aumente a 3-12 mg/día. Vía de administración: oral o intravenosa	Comunes: sedación, confusión y alteración de la memoria (especialmente en adultos mayores), taquicardia, sensación de sequedad en la boca, retención urinaria y estreñimiento. Rara vez, glaucoma de ángulo cerrado, miastenia gravis y obstrucción gastrointestinal.	Precaución en los pacientes con: enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. Interacciones medicamentosas: Tenga cuidado cuando se combina con otros medicamentos anticolinérgicos.
TRIHEXIFENIDIL (Benzhexol)	Comience con 1 mg/día. Aumente a 4-12 mg/día en 3-4 dosis divididas (20 mg/día como máximo). Vía de administración: oral		

CUADRO 3: Estabilizadores del estado de ánimo Si es posible, evite usarlos en mujeres durante el embarazo o la lactancia.

MEDICACIÓN	DOSIFICACIÓN	EFFECTOS SECUNDARIOS	CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES
LITIO  Úselo solo si es factible el seguimiento clínico y de laboratorio.	Comience con 300 mg/día. Aumente gradualmente cada 7 días hasta alcanzar el nivel en sangre proyectado (600-1200 mg/día como máximo). Monitoree cada 2 ó 3 meses. Vía de administración: oral Niveles en sangre deseados: 0,6-1,0 mEq/litro — En el episodio maniaco agudo n: 0,8-1,0 mEq/litro — Para el tratamiento de mantenimiento: 0,6-0,8 mEq/litro. <i>Se requieren 6 meses de medicación para determinar la eficacia total del tratamiento de mantenimiento.</i>	Comunes: sedación, problemas cognoscitivos, temblor, deterioro de la coordinación, hipotensión, leucocitosis, poliuria, polidipsia, náuseas, diarrea, aumento de peso, pérdida del cabello, exantema. Graves: diabetes insípida, hipotiroidismo, alteraciones electrocardiográficas (arritmia, disfunción del nodo sinusal, alteraciones de la onda T).	Contraindicado en los pacientes con: enfermedades cardíacas o renales graves. La deshidratación puede aumentar los niveles de litio. Interacciones medicamentosas: los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los diuréticos tiazídicos, el metronidazol y la tetraciclina pueden aumentar los niveles de litio. La toxicidad del litio puede causar crisis convulsivas, delirio, coma y muerte.
VALPROATO SÓDICO	Comience con 500 mg/día. Aumente lentamente a 1000-2000 mg/día (60 mg/kg/día como máximo). Vía de administración: oral  Opción preferida para personas que viven con la infección por el VIH/SIDA debido a las interacciones medicamentosas.	Comunes: sedación, cefalea, temblor, ataxia, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de peso, pérdida transitoria del cabello. Graves: deterioro de la función hepática, trombocitopenia, leucopenia, somnolencia/confusión, insuficiencia hepática, pancreatitis hemorrágica.	Precaución en los pacientes con: enfermedades subyacentes o presunta hepatopatía. Monitoree las pruebas de la función hepática y las plaquetas si es posible. Interacciones medicamentosas: Los niveles de valproato disminuyen con la carbamazepina y aumentan con la aspirina.
CARBAMAZEPINA	Comience con 200 mg/día Aumente 200 mg semanalmente hasta 400-600 mg/día en dos dosis divididas (1.200 mg/día como máximo). Vía de administración: oral Nota: Puede ser necesario ajustar las dosis después de 2 semanas debido a la inducción de su propio metabolismo.	Comunes: sedación, confusión, mareos, ataxia, visión doble, náuseas, diarrea, leucopenia benigna. Graves: hepatotoxicidad, conducción cardíaca retardada, niveles bajos de sodio, exantema grave.	Contraindicado en los pacientes con: antecedentes de trastornos sanguíneos, renales y hepáticos o cardiopatías. Interacciones medicamentosas. — Puede reducir los efectos del control hormonal de la natalidad, de los medicamentos inmunodepresores, antiepilépticos, antipsicóticos, de la metadona y de algunos antirretrovíricos. — Los niveles en sangre pueden aumentar cuando se administran ciertos antifúngicos y antibióticos.

CUADRO 4: Evalúe la observancia del tratamiento, los efectos secundarios y la dosificación basándose en la situación y las manifestaciones clínicas

SITUACIÓN CLÍNICA	ACCIÓN
La persona no está tolerando la medicación antipsicótica, es decir, la persona tiene síntomas extrapiramidales u otros graves efectos secundarios.	» Reduzca las dosis de la medicación antipsicótica. » Si persisten los efectos secundarios, considere la posibilidad de cambiar a otros medicamentos antipsicóticos. » Considere la posibilidad de agregar medicamentos anticolinérgicos para uso a corto plazo a fin de tratar los síntomas extrapiramidales si fracasan esas estrategias o si los síntomas son graves (vea el Cuadro 2).
La observancia del régimen terapéutico no es satisfactoria.	» Aborde con la persona y los cuidadores las razones de la falta de observancia. » Suministre información con respecto a la importancia de la medicación. » Considere usar medicamentos antipsicóticos inyectables de acción retardada o de acción prolongada como una opción después de examinar los posibles efectos secundarios de la medicación oral en comparación con las preparaciones de acción retardada.
La respuesta al tratamiento es inadecuada (es decir, los síntomas persisten o empeoran) a pesar de la observancia de la medicación.	» Compruebe que la persona está recibiendo una dosis eficaz de los medicamentos. Si la dosis es baja, aumentela gradualmente hasta la dosis eficaz más baja para reducir el riesgo de efectos secundarios. » Pregunte acerca del consumo de alcohol o sustancias y adopte las medidas para reducirlo. Vaya al módulo »SUS. » Pregunte acerca de acontecimientos estresantes recientes que puedan haber conducido a empeorar la afección clínica y adopte medidas para reducir el estrés. » Examine los síntomas para descartar enfermedades físicas u otro tipo de trastornos MNS prioritarios. Vaya al módulo PSI 1, vea el PASO 1 » Considere usar risperidona como una opción para el haloperidol o la clorpromazina, si el costo y la disponibilidad no constituyen una restricción. » Si la persona no responde a la dosis y la duración adecuadas de más de un medicamento antipsicótico, usando un solo medicamento a la vez, se puede considerar el tratamiento antipsicótico combinado, preferentemente bajo la supervisión de un especialista y con un seguimiento clínico muy de cerca. » Considere la consulta con un especialista para el uso de clozapina en los pacientes que no han respondido a otros medicamentos antipsicóticos con dosis y duraciones adecuadas. Use clozapina solo bajo la supervisión de un especialista y solo si dispone de un seguimiento ordinario con pruebas de laboratorio, debido al riesgo de aparición de agranulocitosis en potencia mortal.

CUADRO 5: Manejo de personas con comportamientos agitados o agresivos !

EVALUACIÓN

- » Intente comunicarse con la persona.
- » Evalúela para determinar la causa subyacente:
 - **Determine la glucemia.** Si es baja, suministre glucosa.
 - **Compruebe los signos vitales,** incluídas la temperatura y la saturación de oxígeno. Administre oxígeno de ser necesario.
 - **Descarte el delirio y causas físicas,** incluída la intoxicación.
 - **Descarte el consumo de drogas y alcohol.** Considere específicamente la **intoxicación con estimulantes o la abstinencia de alcohol o sedantes.** Vaya al módulo SUS.
 - **Descarte la agitación debida a la psicosis o a un episodio maníaco en el trastorno bipolar.** Vaya al módulo PSI 1, "Evaluación".

COMUNICACIÓN

- » ¡Primero la seguridad!
- » Manténgase tranquilo y aliente al paciente a que hable sobre sus inquietudes.
- » Use un tono de voz tranquilo y trate de abordar las inquietudes si es posible
- » Escuche atentamente. Dedique tiempo a la persona.
- » Nunca se ría de la persona.
- » No responda agresivamente a la provocación del paciente.
- » Trate de encontrar la fuente del problema y las soluciones para la persona.
- » Haga participar a los cuidadores y otros integrantes del personal.
- » Excluya de la situación a quien pueda ser un factor desencadenante de la agresión.
- » Si se han agotado todas las posibilidades y la persona sigue siendo agresiva, puede ser necesario usar medicación (si la hay) para prevenir lesiones.

SEDACIÓN Y USO DE MEDICACIÓN

- » Sede a la persona según sea apropiado para prevenir lesiones.
- » Para la agitación debida a la psicosis o la manía, considere el uso del haloperidol por vía oral o intramuscular, 2mg por hora hasta 5 dosis (un máximo de 10 mg). *Precaución: las dosis elevadas de haloperidol pueden causar reacciones distónicas. Use biperideno para tratar las reacciones agudas.*
- » Para la agitación debida al consumo de sustancias, como la abstinencia de alcohol o sedantes, o la intoxicación con estimulantes, use diazepam, 10-20 mg administrados por vía oral y repetidos según sea necesario. **Vaya al módulo » SUS.**

En caso de violencia extrema

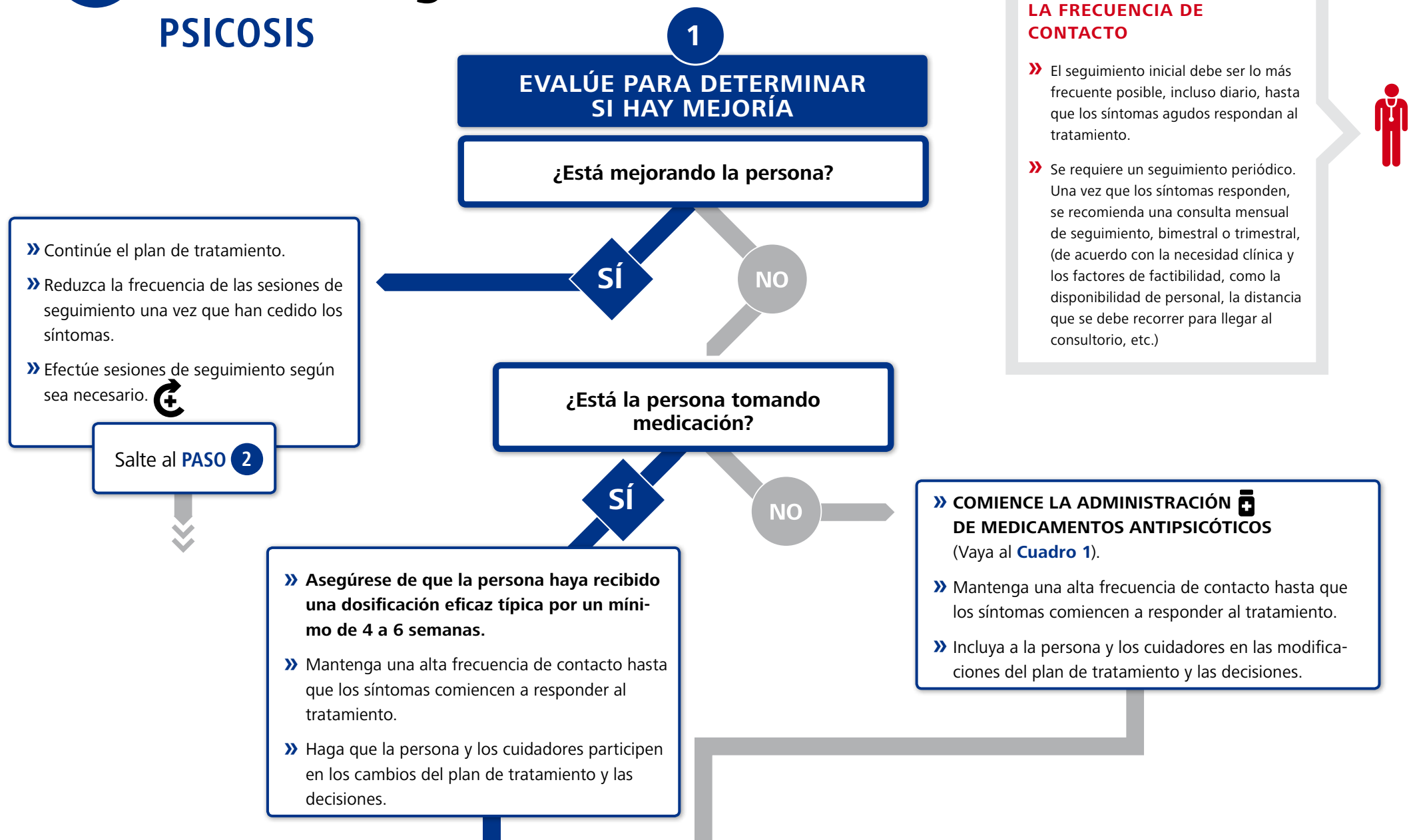
- Busque ayuda de la policía o el personal.
- Use haloperidol en una dosis de 5 mg administrada por vía intramuscular, repetida a los 15-30 minutos de ser necesario (15 mg como máximo).
- Consulte a un especialista. 

- » **Si la persona sigue agitada,** vuelva a verificar la saturación de oxígeno, los signos vitales y la glucemia. Considere la posibilidad de que sienta dolor. Derive a la persona al hospital. 
- » **Una vez que cede la agitación, consulte el Esquema principal y seleccione los módulos pertinentes para la evaluación.**

! Grupos de población especiales:

- Consulte a un especialista para el tratamiento. 

PSI 3 » Seguimiento PSICOSIS



2

MONITOREE SISTEMÁTICAMENTE EL TRATAMIENTO

- » Examine las intervenciones psicosociales.
- » Si la persona está recibiendo medicación, examine la **observancia del tratamiento, los efectos secundarios y la dosificación (Cuadro 4)**. Vigile el peso, la presión arterial y la glucemia.
- » Si la persona comienza a usar otros medicamentos con posibles interacciones medicamentosas, considere la posibilidad de revisar las dosis.
- » Pregunte sobre la aparición de síntomas, episodios anteriores y los detalles previos de todo tratamiento anterior o actual.

3

SUSPENSIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

Persona con un primer episodio, una recaída o un empeoramiento de los síntomas de psicosis:

- » Considere la suspensión de los medicamentos **12 MESES después de que hayan remitido por completo los síntomas**.

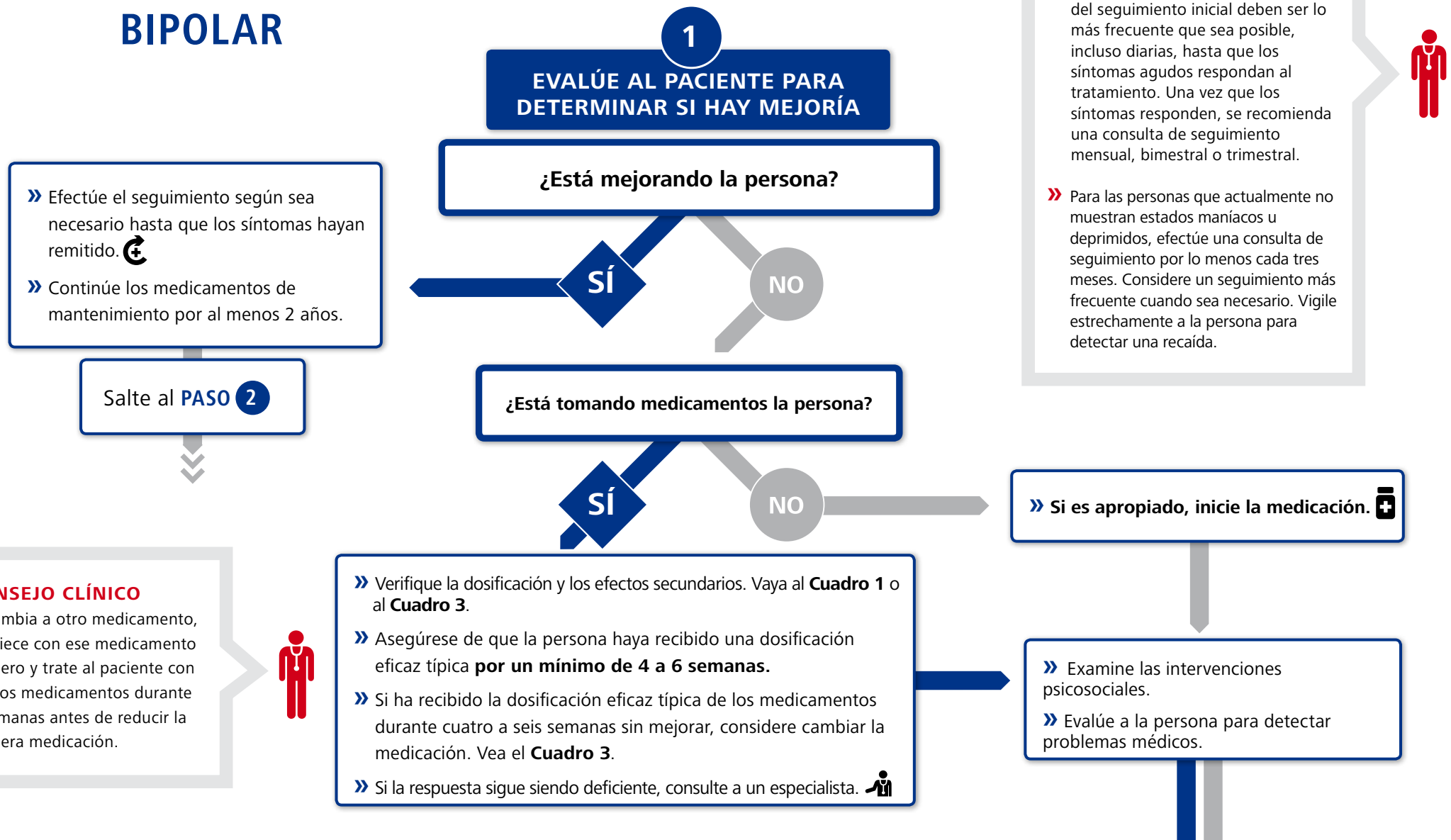
Persona con síntomas psicóticos que persisten más de 3 meses:

- » Considere la suspensión de los medicamentos **si ha habido una REMISIÓN TOTAL de los síntomas durante varios años**.

- » Aborde con la persona y la familia los riesgos de sufrir una recaída, en comparación con los efectos secundarios de la medicación a largo plazo.
- » Si es posible, consulte a un especialista. 
- » Reduzca gradual y lentamente las dosis de los medicamentos. Cuando se suspenden los medicamentos, se debe enseñar a las personas y sus familiares cómo pueden detectar los primeros síntomas de una recaída. Se recomienda una vigilancia clínica minuciosa.

PSI 3 » Seguimiento

EPISODIO MANÍACO EN EL TRASTORNO BIPOLAR



2

MONITOREE SISTEMÁTICAMENTE EL TRATAMIENTO

- » Examine y proporcione intervenciones psicosociales.
- » Si la persona está recibiendo medicamentos, analice la **observancia al tratamiento, los efectos secundarios y la dosificación**. (Vea el **Cuadro 4**).
- » Si la persona comienza a usar otros medicamentos con posibles interacciones medicamentosas, considere la posibilidad de revisar las dosis.

3

SUSPENSIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

¿Ha experimentado la persona una remisión total de los síntomas sin episodios de trastorno bipolar durante al menos dos años?

» Considere la suspensión de los medicamentos.

- Aborde con la persona y el cuidador el riesgo de la suspensión de la medicación.
- Consulte a un especialista con respecto a la decisión de suspender el tratamiento de mantenimiento después de 2 años. 
- Reduzca gradualmente la medicación en un período de semanas o meses.

SÍ

NO

» Efectúe un seguimiento sistemático y vigile el tratamiento. 

AUTOLESIÓN/SUICIDIO

El suicidio es el acto de quitarse la vida deliberadamente. La autolesión es un término más amplio que se refiere al envenenamiento o a la lesión autoinfligida intencional, que puede o no tener una intención o resultado fatal. A toda persona de 10 años de edad o más que presente alguna de las siguientes afecciones se les debe preguntar acerca de pensamientos o planes de autolesión en el último mes, y sobre actos de autolesión en el último año:

- » Cualquiera de los trastornos MNS prioritarios.
Vea el “Esquema principal” (EP)
- » Dolor crónico
- » Alteraciones emocionales agudas



Analice la presencia de pensamientos, planes y actos de autolesión durante la evaluación inicial y posteriormente de forma periódica, según sea necesario. Atienda el estado mental y el malestar emocional de la persona.

CONSEJO CLÍNICO:

Las preguntas sobre autolesiones NO provocan actos de autolesión. A menudo reducen la ansiedad asociada con los pensamientos o los actos de autolesión y ayudan a que la persona se sienta comprendida. Sin embargo, trate de establecer una relación con la persona antes de hacerle preguntas acerca de la autolesión. Pida a la persona que explique cuáles son sus razones para causarse daño.

SUI » Panorama breve



EVALUACIÓN

- » Indague si la persona ha intentado un acto médicamente grave de autolesión.
- » Evalúe si existe un riesgo inminente de autolesión/suicidio.
- » Investigue si está presente alguno de los trastornos MNS prioritarios.
- » Determine si hay dolor crónico.
- » Evalúe la gravedad de los síntomas emocionales.



MANEJO

- » **Protocolos de manejo**
 1. Acto médicamente grave de autolesión
 2. Riesgo inminente de autolesión/suicidio
 3. Riesgo de autolesión/suicidio
- »  **Tratamiento general e intervenciones psicosociales**



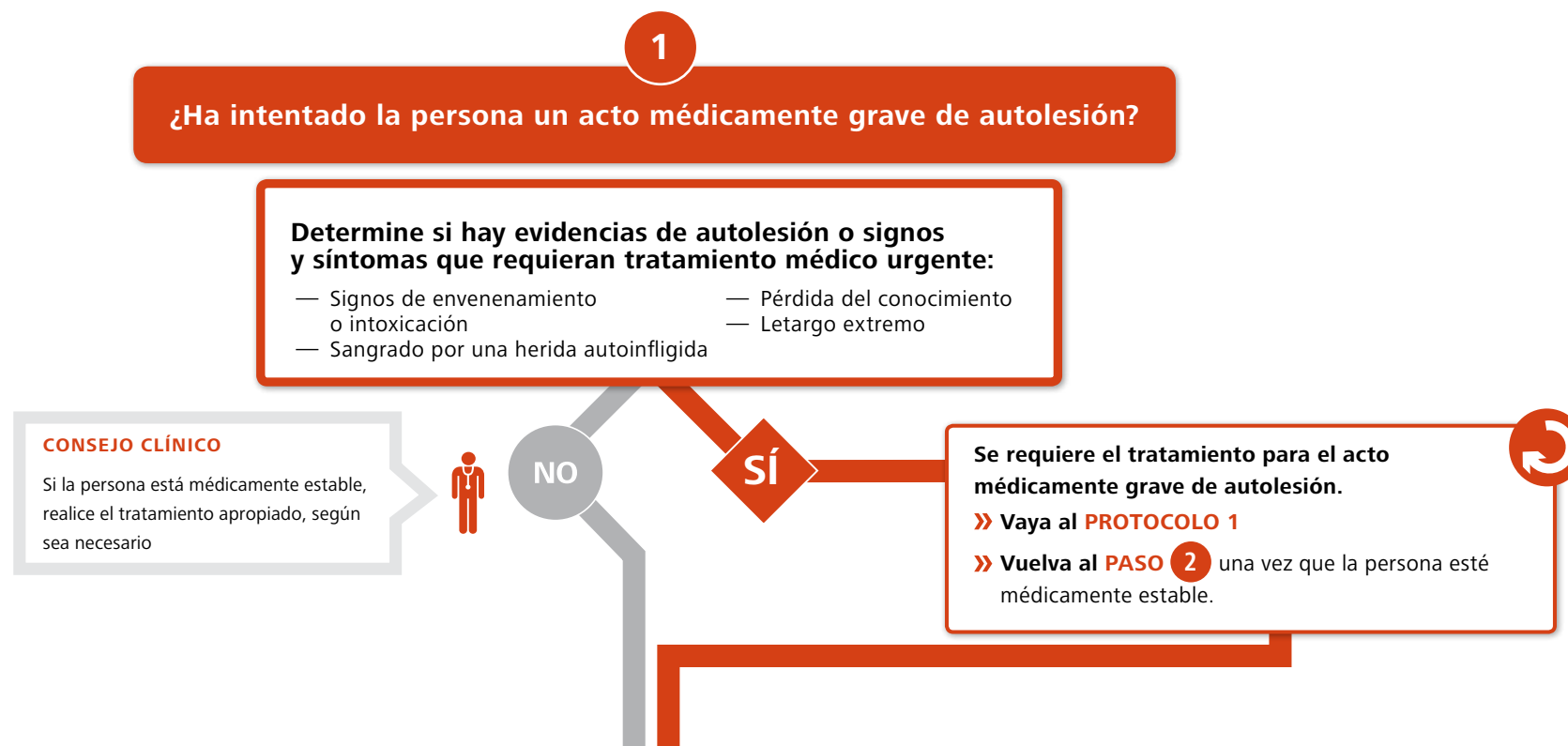
SEGUIMIENTO

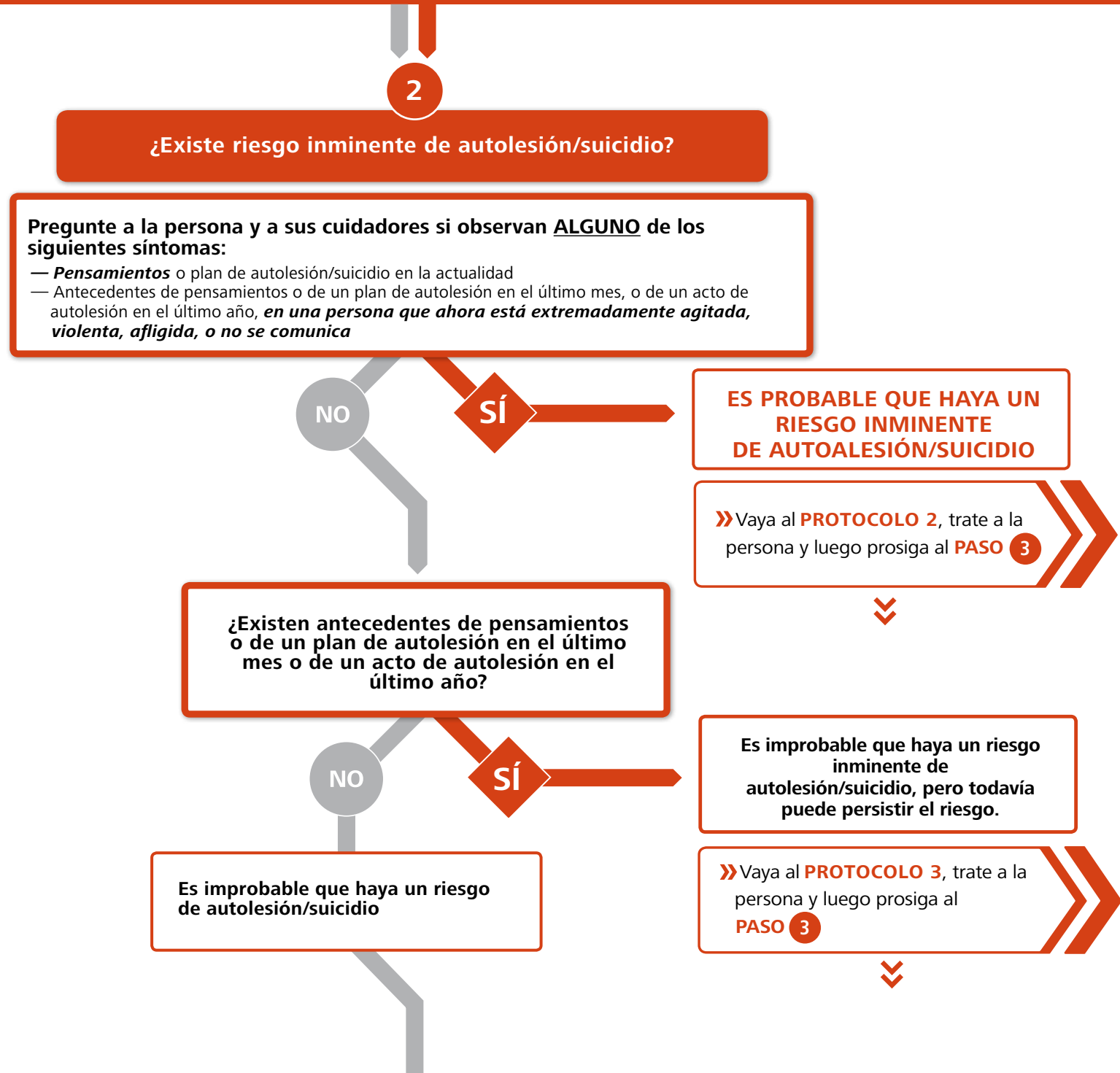


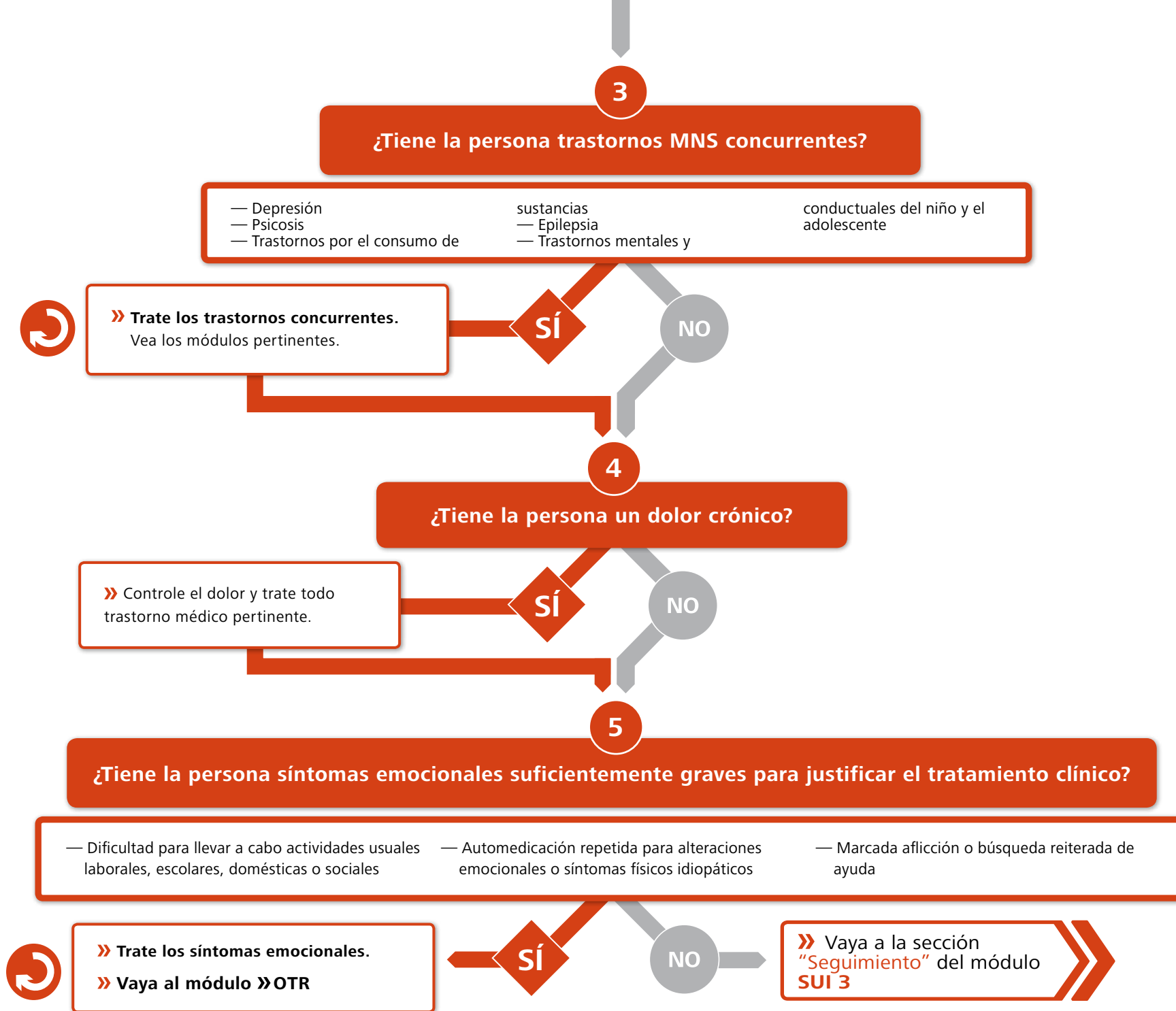
SUI 1 » Evaluación

EVALÚE LA POSIBILIDAD DE AUTOLESIÓN/SUICIDIO SI LA PERSONA PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SIGNOS Y SÍNTOMAS:

- *Desesperanza y desesperación extremas, pensamientos/planes/actos del presente o pasados de autolesión o suicidio, actos de autolesión con signos de envenenamiento o intoxicación, hemorragia por heridas autoinfligidas, pérdida del conocimiento o letargo extremo*
- *Alguno de los trastornos MNS prioritarios, dolor crónico o alteraciones emocionales graves*









SUI 2 » Manejo

PROTOCOLO

1

Acto médicamente grave de autolesión

- » **En todos los casos:** Coloque a la persona en un entorno seguro y propicio en un establecimiento de salud.
- » ❌ NO deje sola a la persona.
- » Trate médicamente la lesión o la intoxicación. Si hay intoxicación aguda con plaguicidas, siga las indicaciones de la sección "Tratamiento de la intoxicación con plaguicidas". (2.1)
- » Si se requiere hospitalización, continúe monitoreando estrechamente a la persona para prevenir el suicidio.
- » Cuide a la persona con autolesión. (2.2)
- » Ofrezca y active el apoyo psicosocial. (2.3)
- » Ofrezcales apoyo a los cuidadores. (2.4)
- » Consulte a un especialista en salud mental, si es factible.
- » Mantenga contacto regular y **seguimiento** periódico.

PROTOCOLO

2

Riesgo inminente de autolesión/suicidio

- » Elimine los medios de autolesión/suicidio.
- » Cree un entorno seguro y propicio; si es posible, ofrezca un área tranquila y separada para esperar el tratamiento.
- » ❌ NO deje sola a la persona.
- » Supervise y asigne a un miembro del personal o a un familiar para garantizar la seguridad de la persona en todo momento.
- » Atienda el estado mental y la alteración emocional.
- » Proporcione psicoeducación a la persona y a sus cuidadores. (2.5)
- » Ofrezca y active el apoyo psicosocial. (2.3)
- » Ofrezcales apoyo a los cuidadores. (2.4)
- » Consulte a un especialista en salud mental, si es factible.
- » Mantenga contacto regular y **seguimiento** periódico.

PROTOCOLO

3

Riesgo de autolesión/suicidio

- » Ofrezca y active el apoyo psicosocial. (2.3)
- » Consulte a un especialista en salud mental, si es factible.
- » Mantenga contacto regular y **seguimiento** periódico.

2.1 Tratamiento de la intoxicación con plaguicidas

- » Si el establecimiento de atención de salud dispone de un conjunto mínimo de capacidades y recursos, trate al paciente usando el documento de la OMS, Clinical Management of Acute Pesticide Intoxication (Manejo clínico de la intoxicación aguda con plaguicidas) http://www.who.int/mental_health/publications/9789241596732/en/, en inglés).

De lo contrario, transfiera a la persona de inmediato a un establecimiento de salud que tenga los siguientes recursos:

- habilidades y conocimientos sobre cómo reanimar a las personas y evaluar para determinar las características clínicas de la intoxicación por plaguicidas;
- capacidad y conocimientos para tratar las vías respiratorias; en particular, para intubar y prestar apoyo respiratorio hasta que se pueda colocar un respirador;
- atropina y medios para su administración intravenosa si se presentan signos de intoxicación colinérgica; y
- diazepam y medios para su administración intravenosa si la persona presenta crisis convulsivas.
- » Considere la posibilidad de administrar carbón activado si la persona está consciente, si da su consentimiento fundamentado y se presenta para la atención una hora después de la intoxicación.
- » No se recomienda la emesis forzada.
- » ❌ No se deben dar líquidos por vía oral.

2.2 Atención a la persona con autolesión

- » Coloque a la persona en un entorno seguro y propicio en un establecimiento de salud (❌ no la deje sola). Si la persona debe esperar el tratamiento, ofrezca un ambiente que reduzca al mínimo el malestar; si es posible, colóquela en un área separada y tranquila, bajo supervisión constante y en contacto con un miembro designado del personal o un familiar para garantizar su seguridad en todo momento.
- » Elimine el acceso a medios de autolesión.
- » Consulte a un especialista en salud mental, si es factible. 
- » Movilice a la familia, los amigos y otras personas pertinentes o a los recursos de la comunidad disponibles para supervisar y apoyar a la persona durante el período de riesgo inminente (vea la sección “Ofrezca y active el apoyo psicosocial”). (2.3)
- » Trate a las personas con autolesión con la misma atención, el respeto y la privacidad otorgados a otras personas y sea sensible al sufrimiento emocional asociado con la autolesión.
- » Incluya a los cuidadores si la persona desea su apoyo durante la evaluación y el tratamiento; si es posible, la evaluación psicosocial debe incluir una entrevista personal entre la persona y el trabajador de salud para abordar temas privados.
- » Preste apoyo emocional a los miembros de la familia y los cuidadores, si lo necesitan. (2.4)

- » Vele por la continuidad de la atención.

- » Para la prevención de la autolesión, no se recomienda la hospitalización en servicios no psiquiátricos de un hospital general. Sin embargo, si el ingreso a un hospital general (no psiquiátrico) es necesario para el manejo de las consecuencias médicas de la autolesión, supervise a la persona estrechamente para prevenir otra autolesión mientras está en el hospital.

» Si receta medicamentos:

- Vea en los módulos pertinentes de la GI-mhGAP las intervenciones farmacológicas para el tratamiento de trastornos concurrentes.
- Use medicamentos que sean menos peligrosos en caso de una sobredosis intencional.
- Entregue prescripciones para períodos breves (por ejemplo, para una semana por vez).

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES

2.3 Ofrezca y active el apoyo psicosocial

» Brinde apoyo a la persona

- Investigue las razones y las formas para permanecer con vida.
- Concéntrese en los puntos fuertes de la persona y aliéntela a hablar sobre cómo se resolvieron problemas anteriores.
- Si cuenta con recursos humanos suficientes, considere la orientación para la resolución de problemas para ayudar a las personas que han cometido actos de autolesión en el último año. Vaya a “Atención y prácticas esenciales de salud” »APE

» Active el apoyo psicosocial

- Movilice a la familia, los amigos, personas interesadas y otros recursos disponibles para garantizar que se vigila estrechamente a la persona mientras persista el riesgo de autolesión/suicidio.
- Recomiende a la persona y los cuidadores que restrinjan el acceso a medios de autolesión/suicidio (por ejemplo, sustancias plaguicidas o tóxicas, medicamentos de prescripción, armas de fuego, etc.) cuando la persona tiene pensamientos o planes de autolesión/suicidio.
- Optimice el apoyo social de los recursos disponibles en la

comunidad. Estos incluyen recursos informales, como familiares, amigos, conocidos, colegas y líderes religiosos; o recursos formales de la comunidad, si los hay, como los centros de crisis y centros locales de salud mental.

2.4 Apoyo a los cuidadores

- » Informe a los cuidadores y los miembros de la familia que preguntar acerca del suicidio a menudo ayudará a la persona a sentirse aliviada, menos ansiosa y mejor comprendida.
- » Los cuidadores y los familiares de las personas en riesgo de autolesión con frecuencia presentan estrés grave. Présteles apoyo emocional si lo necesitan.
- » Informe a los cuidadores que, aunque puedan sentirse frustrados con la persona, deben evitar manifestar hostilidad y críticas severas hacia la persona vulnerable en riesgo de cometer autolesión/suicidio.

2.5 Psicoeducación

» Mensajes fundamentales para la persona y los cuidadores

- Si tiene pensamientos de autolesión/suicidio, busque ayuda de inmediato recurriendo a un familiar confiable, un amigo o un prestador de atención de salud.
- Está bien hablar del suicidio. Hablar del suicidio no provoca el acto de suicidio.
- Los suicidios son prevenibles.
- Tener un episodio de autolesión/suicidio es un indicador de sufrimiento emocional grave. La persona no ve una opción o una solución. Por consiguiente, es importante hacerle llegar a la persona apoyo inmediato para afrontar los problemas emocionales y los factores estresantes.
- Se deben retirar del hogar los medios de autolesión (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego, medicamentos).
- La red de relaciones sociales, que incluye a la familia y otras personas pertinentes, es importante para proporcionar apoyo social.

SUI 3 » Seguimiento



OTROS PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL IMPORTANTES

Este módulo procura proporcionar orientación básica sobre el manejo de una variedad de afecciones de salud mental no abarcadas en otra parte de esta guía. Algunas de estas afecciones pueden ser similares a la depresión, pero un examen más minucioso permite diferenciarlas de los trastornos cubiertos en esta guía.

Otros padecimientos de salud mental son considerados importantes cuando deterioran el funcionamiento o cuando la persona busca ayuda para tratarlos. Algunas enfermedades de salud mental pueden atribuirse al estrés.

- » No se debe considerar este módulo para las personas que satisfacen los criterios para definir alguno de los trastornos prioritarios abarcados por el mhGAP (excepto la autolesión).
- » Este módulo solo debe usarse después de descartar explícitamente la depresión.
- » Se debe usar este módulo cuando se ayuda a adultos. En caso de que la persona sea un niño o adolescente, vaya al módulo » MCON.

OTR » Panorama breve



EVALUACIÓN

- » Descarte causas físicas que explicarían plenamente los síntomas que se manifiestan.
- » Descarte la depresión u otros trastornos MNS.
- » Investigue si la persona está buscando ayuda para aliviar síntomas o tiene considerable dificultades en el funcionamiento diario.
- » Indague si la persona ha estado expuesta a factores estresantes extremos.
- » Evalúe si hay un riesgo inminente de autolesión/suicidio.



MANEJO

- » **Protocolos de manejo**
 1. Otros padecimientos de salud mental importantes
 2. Otros padecimientos de salud mental importantes en personas expuestas a factores estresantes extremos



SEGUIMIENTO



OTR 1 » Evaluación

MANIFESTACIONES COMUNES DE OTROS PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL IMPORTANTES

- La persona se siente extremadamente cansada, deprimida, irritada, ansiosa o estresada.
- La persona presenta síntomas somáticos sin causa médica discernible (por ejemplo, síntomas somáticos sin una causa física conocida que explique plenamente los síntomas).

1

¿Hay una causa física que explica por completo los síntomas que se manifiestan?

SÍ

» Trate toda causa física identificada y examine nuevamente a la persona para ver si persisten los síntomas.

NO

2

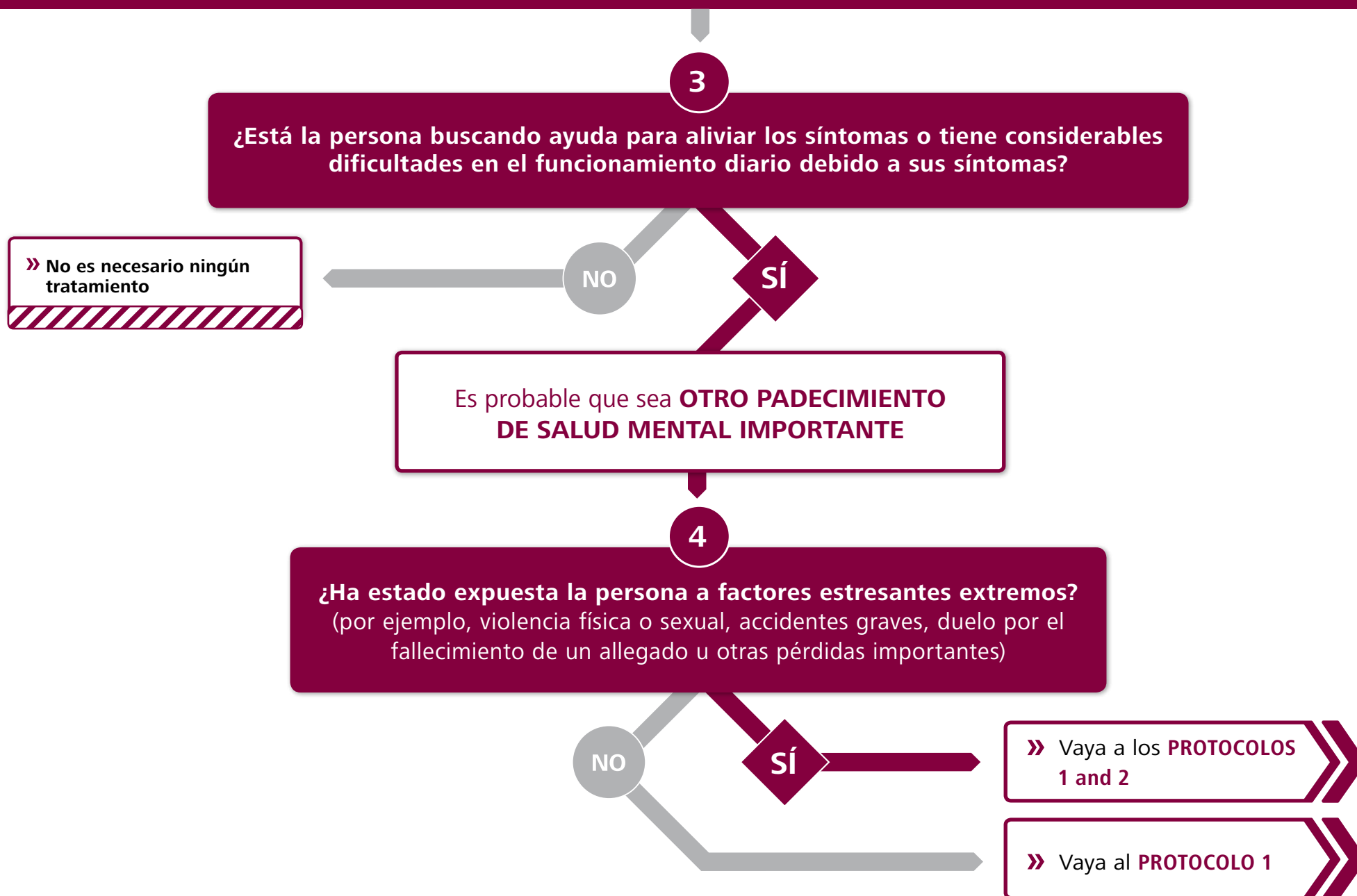
¿La depresión u otro trastorno MNS son abordados en otro módulo de esta guía?

SÍ

» Vaya al módulo pertinente.

NO





! SI HAY RIESGO INMINENTE DE SUICIDIO, EVALÚE Y TRATE a la persona antes de proseguir con los protocolos 1 y 2 (Vaya al módulo »SUI).





OTR 2 » Manejo

PROTOCOLO

1

OTROS PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL IMPORTANTES

- » ❌ **NO recete medicamentos ansiolíticos o antidepresivos** (a menos que sea asesorado por un especialista).
- » ❌ **NO aplique inyecciones de vitaminas u otros tratamientos ineficaces.**
- » **En todos los casos, reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales como se describe en el módulo “Atención y prácticas esenciales de salud” (APE).**
 - Aborde los factores psicosociales estresantes actuales.
 - Fortalezca los apoyos.
 - Enseñe a manejar el estrés, por ejemplo, mediante técnicas de relajación (vea el **Cuadro 1** al final del módulo).
- » **Cuando no se identifica ningún trastorno físico que explique plenamente un síntoma somático que se manifiesta, reconozca la realidad de los síntomas y determine explicaciones posibles.**
 - Evite pedir más pruebas de laboratorio u otros estudios a menos que exista una indicación médica clara; por ejemplo, signos vitales anormales.
 - En caso que, de todos modos, se ordene un estudio adicional, reduzca las expectativas poco realistas y dígame a la persona que el resultado previsto probablemente será normal.
- Informe a la persona que no se ha identificado ninguna enfermedad grave. Comunique los resultados normales del examen clínico y de las pruebas.
- Si la persona insiste en que se realicen estudios adicionales, considere la posibilidad de decirle que llevar a cabo estudios que no son necesarios puede ser perjudicial para ella porque pueden causar preocupación innecesaria y efectos secundarios.
- Reconozca que los síntomas no son imaginarios y que todavía es importante abordar los síntomas que causan un malestar significativo.
- Pida a la persona su propia explicación de la causa de sus síntomas y pregúntele sobre sus inquietudes. Esto puede dar indicios acerca del origen del malestar, ayudar a establecer una relación de confianza con la persona y aumentar el cumplimiento del régimen terapéutico.
- Explique que el sufrimiento emocional o el estrés a menudo incluyen sensaciones físicas, como dolor de estómago, tensión muscular, etc. Investigue y aborde posibles vínculos entre las emociones o el estrés y los síntomas.
- Promueva la continuación de las actividades diarias (o el retorno gradual a esas actividades).
- Acuérdesse de aplicar la práctica de reducción del estrés y el fortalecimiento del apoyo social. Vaya al módulo **» APE**.

PROTOCOLO

2

**OTROS PADECIMIENTOS DE SALUD MENTAL IMPORTANTES
EN PERSONAS EXPUESTAS A FACTORES ESTRESANTES EXTREMOS**

(por ejemplo, violencia física o sexual, accidentes graves, duelo por el fallecimiento de un allegado u otras pérdidas importantes)

» En todos los casos, ya sea que la persona presente o no problemas emocionales, físicos o conductuales después de la exposición a un factor en extremo estresante, préstele apoyo según se describe en el PROTOCOLO 1. Escuche atentamente.

» ❌ NO presione a la persona para que hable del suceso.

» Atienda las necesidades sociales de la persona.

- **Pregunte** a la persona acerca de sus necesidades e inquietudes.
- **Ayude** a la persona a atender sus necesidades básicas, tener acceso a los servicios y conectarse con su familia y otros apoyos sociales.
- **Proteja** a la persona de (mayores) daños, de ser necesario.
- **Aliente** a la persona a que regrese a sus actividades normales anteriores, por ejemplo, escolares o laborales, domésticas y sociales, si es factible y culturalmente apropiado.

» En el caso de una pérdida importante explique que:

- Es normal lamentar toda pérdida importante. Uno puede lamentar la pérdida de una persona, un lugar o una propiedad o la pérdida de su propia salud y bienestar. La aflicción tiene efectos tanto mentales como físicos.
- Las personas se afligen de diferentes maneras. Algunas personas muestran

emociones fuertes mientras que otras no las manifiestan. El llanto no significa que uno es débil. Las personas que no lloran pueden sentir un dolor emocional igualmente profundo, pero tienen otras formas de expresarlo.

- En la mayoría de los casos, la aflicción disminuirá con el transcurso del tiempo. Uno puede pensar que la tristeza, la añoranza o el dolor que siente nunca desaparecerán, pero, en la mayoría de los casos, estos sentimientos se disipan con el transcurso del tiempo. A veces una persona puede sentirse bien durante algún tiempo, luego algo le recuerda la pérdida y pueden sentirse tan mal como al principio. No hay una manera correcta o errónea de sentir aflicción. A veces, quizás uno se sienta muy triste, otras veces, permanezca insensible, y en otros momentos tal vez pueda sentir alegría. Estas experiencias se vuelven generalmente menos intensas y menos frecuentes con el transcurso del tiempo.

» En caso de la pérdida de un ser querido, aborde la pérdida y brinde apoyo para el ajuste o para procesos de duelo culturalmente apropiados.

- Pregunte si se han realizado o planeado ceremonias o rituales de duelo. Si no es este el caso, examine los obstáculos y cómo abordarlos.

» Si se sospecha que existe un trastorno de duelo prolongado, consulte a un especialista para una nueva evaluación y manejo. 

- La persona puede haber prolongado el trastorno de duelo si los síntomas implican considerables dificultades en el funcionamiento diario **durante al menos 6**

meses e incluyen preocupación grave o nostalgia intensa por la persona difunta, acompañada de un intenso dolor emocional.

» **En el caso de reacciones a la exposición reciente a un suceso potencialmente traumático, explique que:**

- Las personas a menudo tienen reacciones después de sucesos de ese tipo. Las reacciones pueden ser sumamente variables de una persona a otra y cambiar con el transcurso del tiempo.
- Pueden incluir síntomas somáticos como palpitaciones, achaques y dolores, alteraciones gástricas y cefaleas y síntomas emocionales y conductuales como perturbación del sueño, tristeza, ansiedad, irritación y agresión.
- Esos sentimientos se pueden exacerbar o pueden reaparecer cuando se presentan recordatorios del acontecimiento estresante o nuevos factores estresantes.

- En la mayoría de los casos, los síntomas probablemente disminuyan con el transcurso del tiempo, en particular, si la persona descansa o recibe apoyo social y se ocupa de reducir del estrés. Vaya al módulo »**APE**. Vaya al **Cuadro 1**.

» **Si se sospecha que existe un trastorno de estrés postraumático (TEPT), consulte a un especialista para una nueva evaluación y manejo.**

- Después de un suceso en potencia traumático, tal vez la persona sufra un trastorno por estrés postraumático si los síntomas incluyen considerables dificultades en el funcionamiento diario **por al menos 1 mes** y la recurrencia de sueños atemorizantes, escenas retrospectivas o la intrusión de recuerdos del suceso, acompañados de temor u horror intensos; evitar deliberadamente recordatorios del suceso; inquietud excesiva y estado de alerta a un peligro; o reacción desmesurada a ruidos fuertes o movimientos inesperados.

OTR 3 » Seguimiento

EVALÚE AL PACIENTE PARA DETERMINAR SI HAY MEJORÍA

¿Está mejorando la persona?

SÍ

NO

- » Continúe con el plan de tratamiento.
- » Efectúe el seguimiento según sea necesario. 

Si la persona no está mejorando **o la persona o el cuidador insisten en que se realicen otras investigaciones y tratamiento:**

- » Examine los protocolos 1 y 2.
- » Considere la posibilidad de consultar a un especialista. 

RECOMENDACIONES SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTACTO

- » Pídale a la persona que regrese en 2 ó 4 semanas si sus síntomas no mejoran o si, en cualquier momento, sus síntomas empeoran.



CUADRO 1: INSTRUCCIONES PARA LA CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

» Explique lo que hará usted.

“Voy a enseñarle cómo respirar de una manera que le ayudará a relajar el cuerpo y la mente. Tomará algo de práctica antes de que usted sienta los beneficios totales de esta técnica respiratoria. La razón de que esta estrategia se concentre en la respiración es que, cuando nos sentimos estresados, nuestra respiración se vuelve rápida y poco profunda, lo cual nos hace sentir más tensos. Para empezar a relajarse, usted tiene primero que cambiar su respiración. Antes de comenzar relajaremos el cuerpo”.

» Comience lentamente los ejercicios de relajación y demuestre cómo respirar.

“Agite y afloje suavemente los brazos y las piernas. Déjelos blandos y flojos. Haga retroceder los hombros y mueva suavemente la cabeza de un lado a otro. Ahora coloque una mano sobre la barriga y la otra mano sobre la parte superior del tórax. Quiero que se imagine que tiene un globo en su estómago y que, cuando inhale, va a inflar ese globo de tal modo que su estómago se dilatará. Y cuando exhale, también saldrá el aire del globo, y así se aplanará su estómago. Primero observe cómo lo hago. Voy a exhalar primero para sacar todo el aire de mi estómago”. Demuestre cómo respirar desde el estómago; trate de exagerar la dilatación y la contracción de su estómago.

» Concéntrese en las técnicas de respiración.

“Trate de respirar desde el estómago conmigo. Recuerde que comenzamos exhalando hasta que alga todo el aire; luego inhale. Si puede, inhale el aire por la nariz y exhálolo por la boca. El segundo paso es desacelerar el ritmo de su respiración. Tome tres segundos para inhalar el aire, dos segundos para retenerlo y tres segundos para exhalarlo. Contaré con usted. Puede cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Lentamente inhale, 1, 2, 3. Retenga, 1, 2. Ahora exhale, 1, 2, 3”. Repita este ejercicio respiratorio durante aproximadamente un minuto, descanse durante un minuto y luego repita el ciclo dos veces más.

» Promueva la autopráctica.

“Trate hacerlo solo durante un minuto. Esto es algo que usted puede practicar por sí solo”.